

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL
DENGAN
RS
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN
PESERTA ASURANSI KESEHATAN DAN *ADMINISTRATION SERVICE ONLY (ASO)*
PT ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL**

Nomor PIHAK PERTAMA :
Nomor PIHAK KEDUA :

Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelayanan Kesehatan, Perawatan dan Obat Peserta Asuransi Kesehatan Dan Administration Service Only (ASO) PT Asuransi Perisai Listrik Nasional ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Selasa tanggal, oleh dan antara:

I. **PT ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL**, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 112 tanggal 21 Agustus 1991 yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris Indonesia Nomor 02-5386.HT.01.01.TH.91 pada tanggal 3 Oktober 1991 atas nama PT Asuransi Ratu Sampoerna dan Akta Perubahan Nama Menjadi PT Asuransi Tugu Kresna Pratama tertanggal 2 Juni 1993 Nomor 06 dibuat di hadapan Notaris Muhani Salim, S.H., yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor : 02-4988.HT.01.04 Tahun 1993 dan Akta Perubahan Nama Menjadi PT Asuransi Perisai Listrik Nasional tertanggal 13 Mei 2020 Nomor 02 dibuat di hadapan Notaris Ida Murtamsa Salim, S.H., M.Kn. di Jakarta, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor: AHU-0055226.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 05 Agustus 2022 sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Akta Notaris Mundji Salim, S.H., M.Kn. Nomor: 69 tanggal 20 Maret 2025 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0164948 Tahun 2025 tanggal 25 Maret 2025 yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu No. 5, Jakarta Selatan 12780, dalam hal ini diwakili **oleh Moch. Hirmas Fuady** selaku Presiden Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Perisai Listrik Nasional selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";

II. ***PT DISA PRIMA MEDIKA** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, Anggaran Dasar Perusahaan dimuat dalam Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S. H, Sarjana Hukum, Notaris Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01. Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan) serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat dihadapan Yudo Sigit Riswanto, S.H, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE** dalam jabatannya selaku Direktur Utama yang berkedudukan dan berkantor di Banjararum No 3B, Mondoroko, Singosari Malang selaku pemilik dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit – Rumah Sakit** yang disebutkan di bawah ini :

A. **Rumah Sakit Prima Husada Malang** dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur mazidah sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS.

sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan. Selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

1. PIHAK PERTAMA adalah perusahaan Asuransi Umum yang memiliki jasa pelayanan Asuransi Kesehatan dan ASO bagi Peserta yang terdaftar untuk menerima pelayanan kesehatan dari Pihak/Institusi/Lembaga Pelayanan Kesehatan yang mempunyai ijin resmi dan terdaftar pada Lembaga Pemerintahan yang berwenang.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan afiliasi dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) yang didirikan oleh PT PLN (Persero).
3. Bahwa sehubungan dengan adanya peralihan pengelolaan layanan kesehatan Peserta dari PT PLN (Persero) (selanjutnya disebut "PLN (Persero)") untuk para pegawai dan pensiunan yang ditanggung beserta dengan keluarganya yang sebelumnya dikelola oleh PT PLN (Persero) menjadi dikelola oleh APLN berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PLN (Persero) dan PIHAK PERTAMA, Nomor: 2128.PJ/HKM.02.01/F01080300/2024; Nomor:1214/PKS/DIR-APLN/XII/2024, tanggal 31 Desember 2024 ("PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN PLN"),
4. Bahwa sejalan dengan surat dari PLN (Persero) kepada PIHAK KEDUA dan surat dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut:
 - a. Surat dari PT PLN (Persero) Yan HC Regional Jawa, Madura, dan Bali yang ditujukan kepada Pimpinan Provider Kesehatan Nomor:0366/SDM.09.01/ F01080300/2025 tanggal 3 Januari 2025, perihal Kerjasama Layanan Kesehatan;
 - b. Surat dari PIHAK PERTAMA yang ditujukan kepada Provider Rekanan Nomor:003/PVD-ASKES/APLN/I/2025 tanggal 1 Januari 2025, perihal Pemberitahuan Transformasi, Mekanisme, dan Ketentuan Layanan Kesehatan Peserta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
5. PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit yang telah mempunyai ijin resmi dan terdaftar pada Lembaga Pemerintahan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat umum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelayanan Kesehatan, Perawatan dan Obat Peserta Asuransi Kesehatan Dan Administration Service Only (ASO) PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 UMUM

- (1) Istilah-istilah yang digunakan dalam PERJANJIAN ini beserta pengertiannya selain yang telah disebutkan di atas maupun dalam pasal-pasal di dalam PERJANJIAN ini, dimuat dalam Lampiran I.
- (2) Kata-kata dalam bentuk tunggal dapat mencakup bentuk jamak atau sebaliknya, dan kata yang menyatakan kata ganti orang dapat mencakup kata ganti benda, termasuk perseorangan, perusahaan, kemitraan, asosiasi, bentuk kerja sama lainnya, pemerintahan dan badan-badan pemerintah.
- (3) Setiap dan semua Lampiran yang disebut dan dilampirkan pada PERJANJIAN ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari PERJANJIAN ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam kerja sama Penyediaan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta oleh PIHAK KEDUA yang sebelum ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam PERJANJIAN.
- (2) Tujuan dari PERJANJIAN ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan kerja sama sesuai peran serta PARA PIHAK, dengan mengatur kembali syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam PERJANJIAN guna memudahkan PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama Penyediaan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta.

PASAL 3 LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Penyediaan Layanan Kesehatan oleh PIHAK KEDUA yang dilakukan melalui Rumah Sakit PIHAK PERTAMA sebagaimana dimuat dalam LAMPIRAN VI selanjutnya disebut "Penyedia Layanan Kesehatan")
- (2) Lingkup Pelayanan Kesehatan oleh PIHAK KEDUA kepada Peserta PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Lampiran II, meliputi:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Instalasi Gawat Darurat (IGD);
 - d. Instalasi Farmasi (obat-obatan);
 - e. Pelayanan Penunjang;
 - f. Rawat Gigi
- (3) Pelayanan Kesehatan PIHAK KEDUA kepada Peserta PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas adalah sesuai dengan manfaat kesehatan (*benefit plan*) masing-masing Peserta yang termuat pada *Front End System* PIHAK PERTAMA dan dibuktikan eligibilitasnya berdasarkan Kartu Peserta atau *e-card* yang masih berlaku.
- (4) Pengecualian atas Pelayanan Kesehatan dan prosedur Pelayanan Kesehatan diatur dalam Lampiran III.
- (5) PIHAK PERTAMA akan menyampaikan daftar Klien kepada PIHAK KEDUA melalui surat dan email dan akan diperbaharui secara terus menerus sebagaimana ditentukan dalam Lampiran VII.
- (6) Syarat dan ketentuan dalam PERJANJIAN ini dan Lampirannya menjadi acuan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dan/atau PARA PIHAK berkenaan dengan pelayanan kesehatan, perawatan dan obat oleh PIHAK KEDUA kepada Peserta.

PASAL 4 SKEMA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN PEMANFAATAN KEPESERTAAN PADA BPJS KESEHATAN

- (1) Peserta merupakan Peserta aktif pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan, oleh karenanya untuk Pelayanan Kesehatan PIHAK KEDUA yang telah memiliki mekanisme pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar mengoptimalkan pemanfaatan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam perhitungan dan penagihan biaya dengan menggunakan program koordinasi manfaat/*cost-splitting/split-billing*. Pemanfaatan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam perhitungan dan penagihan biaya dilaksanakan dengan tetap memperhatikan serta tidak menyalahi segala ketentuan dan peraturan terkait yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memastikan standar layanan yang diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan layanan yang disepakati (tidak ada penurunan standar) dalam pemanfaatan kePesertaan pada BPJS Kesehatan.

- (3) Penagihan PIHAK KEDUA, yang telah memiliki mekanisme pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ditujukan kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan perhitungan biaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan tarif pelayanan dan pengobatan yang berlaku pada PIHAK KEDUA setelah dikurangi biaya berdasarkan ketentuan tarif INA-CBGs yang ditagihkan kepada BPJS Kesehatan, untuk kemudian selisihnya ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Jika terdapat selisih tarif pembayaran akibat adanya perubahan *coding* BPJS Kesehatan, maka PIHAK KEDUA menyampaikan alasan BPJS Kesehatan terhadap perubahan *coding* tersebut kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya dilakukan pembayaran susulan kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Jika PIHAK PERTAMA terdapat kelebihan pembayaran akibat adanya perubahan *coding* BPJS Kesehatan maka PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan pengembalian biaya.
- (6) Informasi terkait data kepesertaan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diinformasikan kepada PIHAK KEDUA melalui PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Tanpa mengesampingkan hak PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal lain dari PERJANJIAN ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. Melakukan evaluasi dan penilaian atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan PIHAK KEDUA sesuai dengan jenis dan/atau klasifikasi Provider dengan cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada, mendapatkan data dan informasi tentang fasilitas PIHAK KEDUA, kunjungan Peserta, rata-rata jumlah hari rawat inap, dan tingkat kepuasan Peserta.
 - b. Melakukan penilaian atas Pelayanan Obat yang diberikan PIHAK KEDUA dengan cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada, mendapatkan data dan informasi tentang fasilitas PIHAK KEDUA, jenis dan ketersediaan obat yang diberikan kepada Peserta, dan kepuasan Peserta.
 - c. Memeriksa riwayat medis (*Medical Record*) dan bukti pelayanan Peserta, apabila diperlukan.
 - d. Memberikan teguran tertulis atau peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA menemukan terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN ini.
 - e. Pengakhiran dan pemutusan kerja sama berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a pada PERJANJIAN ini apabila setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut, PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban ataupun memperbaiki penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan PERJANJIAN ini.
- (2) Tanpa mengesampingkan kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari PERJANJIAN ini, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Membayar biaya pelayanan atas Pelayanan Kesehatan, Perawatan dan Pelayanan Obat yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Peserta, sesuai tagihan yang diajukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
 - b. Membayar biaya Pelayanan Obat yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Peserta, sesuai tagihan yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA, sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
 - c. Bersama-sama PIHAK KEDUA, melakukan sosialisasi, prosedur pelayanan, tata cara pengajuan klaim, kepada PIHAK yang berkepentingan.
 - d. Bersama-sama PIHAK KEDUA, melakukan sosialisasi, tata cara pengajuan klaim, kepada PIHAK yang berkepentingan.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Tanpa mengesampingkan hak PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari PERJANJIAN ini, maka PIHAK KEDUA berhak untuk:
- Memperoleh pembayaran biaya pelayanan dari PIHAK PERTAMA atas Pelayanan Kesehatan dan yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Peserta sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.
 - Memperoleh informasi tentang Peserta yang berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan.
 - Memperoleh informasi tentang ruang lingkup dan prosedur Pelayanan Kesehatan yang disediakan kepada Peserta.
 - Memperoleh informasi tentang tata cara pembayaran atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Tanpa mengesampingkan kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari PERJANJIAN ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- Melayani Peserta dengan baik sesuai dengan standar, prosedur dan mutu Pelayanan Kesehatan serta Pelayanan Obat yang berlaku bagi Rumah Sakit sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menyediakan data dan informasi tentang fasilitas PIHAK KEDUA, kunjungan Peserta, rata-rata jumlah hari rawat inap, tingkat kepuasan Peserta, termasuk *Medical Record* dan bukti pelayanan Peserta, apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.
 - Menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat tentang fasilitas dan Pelayanan Kesehatan serta Pelayanan Obat yang diberikan kepada Peserta terkait evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
 - Mengajukan tagihan atas biaya Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Obat Peserta secara teratur setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
 - Menjamin dan mengutamakan penulisan resep obat bagi Peserta yang berpedoman pada Daftar Obat yang berlaku.
 - Menyediakan dokter-dokter untuk kebutuhan Peserta sesuai dengan jam kerja Dokter pada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA wajib menyediakan penggantinya dalam hal Dokter yang disediakan berhalangan dan/atau tidak lagi bekerja atau berpraktik di PIHAK KEDUA.
 - Sehubungan dengan ketentuan ayat (2) huruf f Pasal ini, PIHAK KEDUA wajib memastikan bahwa Dokter yang bekerja atau berpraktek di PIHAK KEDUA mematuhi ruang lingkup dan prosedur pelayanan yang ditetapkan dalam PERJANJIAN ini
 - Menjamin ketersediaan dan kecukupan obat-obatan yang tercakup dalam Daftar Obat.
 - Memberikan obat-obatan kepada Peserta berdasarkan resep obat yang diterima dengan tetap berpedoman kepada Daftar Obat.
 - Mengikuti proses evaluasi dan penilaian yang dilakukan secara berkala oleh PIHAK PERTAMA.
 - Mengajukan tagihan atas biaya Pelayanan Kesehatan dan/atau Pelayanan Obat Peserta secara teratur sesuai ketentuan mengacu kepada Pasal 13 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.
 - PIHAK KEDUA juga berkewajiban atas:
 - Tidak ada penyimpangan pemeriksaan kesehatan, pemberian tindakan, pemberian resep obat, dan rujukan dalam pelaksanaan kesehatan.
 - PIHAK KEDUA memberikan informasi tertulis terkait kondisi kesehatan Peserta sesuai permintaan PIHAK PERTAMA
 - Melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya.
 - Dalam hal fasilitas atau kondisi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat mengatasi penyakit peserta, wajib merujuk ke rumah sakit lain yang mampu menyediakan fasilitas yang lebih lengkap dan diprioritaskan di rujuk ke rumah sakit yang bekerja sama oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul berdasarkan PERJANJIAN ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan

sesuai dengan ketentuan dalam PERJANJIAN ini atau berdasarkan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kerja sama berdasarkan PERJANJIAN ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga masing-masing PIHAK ("AD/ART") serta tidak melanggar peraturan pemerintah maupun undang-undang yang berlaku;
 - b. Wakil dari masing-masing PIHAK yang menandatangani PERJANJIAN ini memiliki hak secara hukum serta memiliki kuasa dan wewenang penuh untuk menandatangani serta telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan ("AD/ART"), diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan PERJANJIAN ini secara menyeluruh; dan
 - c. Masing-masing PIHAK wajib memastikan agar maksud dan tujuan PARA PIHAK serta semua hal yang disepakati dan diatur dalam PERJANJIAN ini dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa dalam hal memberikan informasi tertulis terkait kondisi kesehatan Peserta sesuai Permintaan PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada Penyimpangan Pemeriksaan Kesehatan, Pemberian Tindakan, Pemberian Resep Obat, dan Rujukan dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan; dan akan memberikan Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Obat kepada Peserta sebagaimana diatur dalam lampiran-lampiran PERJANJIAN ini.
- (4) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin akan bertanggung jawab secara penuh dan membebaskan PIHAK PERTAMA terhadap segala kerugian yang timbul dan/atau tuntutan yang diajukan oleh Peserta dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian atas tindakan dalam Pelayanan Kesehatan kepada Peserta yang terjadi dan atau disebabkan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA menjamin Pelaksanaan Kendali Mutu dan Kendali Biaya.
- (6) PIHAK KEDUA menjamin tingkat optimalisasi Pemanfaatan Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan yang dikombinasikan dengan Jaminan Kesehatan PIHAK PERTAMA sejauh memungkinkan dan memenuhi Ketentuan.

PASAL 8 TAHAP EVALUASI DAN PENILAIAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib mengikuti tahap evaluasi dan penilaian kesiapan dan kelayakan atau Kredensialing dan Rekredensialing sebagai Provider sesuai dengan jenis layanan yang disediakan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Ruang Lingkup dari:
 - a. Evaluasi dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. kelengkapan administrasi terkait dengan pelayanan; dan
 - ii. kualitas/mutu Layanan.Evaluasi tersebut dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu selama berlangsungnya kerja sama.
 - b. Kredensialing dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. legalitas (usaha dan petugas medis); dan
 - ii. kapasitas dan kualitas dari fasilitas kesehatan
 - c. Rekredensialing dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud

- (3) PIHAK PERTAMA akan mengirimkan pemberitahuan tertulis hasil dari evaluasi dan Kredensialing dan Rekredensialing yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini beserta rekomendasi yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA dinyatakan tidak lulus tahap Kredensialing maupun Rekredensialing sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan peninjauan atas PERJANJIAN ini dengan pengakhiran atau pemutusan kerja sama atau melanjutkan dengan melakukan perubahan terhadap syarat dan ketentuan dalam PERJANJIAN ini.
- (5) Dalam hal PIHAK KEDUA dinyatakan tidak lulus tahap Kredensialing dan atas hal tersebut PIHAK PERTAMA memutuskan untuk melakukan pengakhiran dan/atau pemutusan kerja sama maka hal pengakhiran dan/atau pemutusan kerja sama tersebut akan disebutkan dalam pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas.
- (6) Dalam hal PIHAK KEDUA dinyatakan tidak lulus tahap Evaluasi ataupun tahap Rekredensialing, dan atas hal tersebut PIHAK PERTAMA memutuskan untuk melakukan pengakhiran dan/atau pemutusan kerja sama maka untuk pengakhirannya tunduk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a PERJANJIAN ini.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Kerja sama PARA PIHAK dalam penyediaan Pelayanan Kesehatan dimulai terhitung sejak tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) sampai tanggal tiga satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh tujuh(30-12-2027) dengan ("Jangka Waktu Kerja Sama")
- (2) Jangka Waktu Kerja Sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Sebaliknya PERJANJIAN ini dapat diakhiri atau diputus sebelum tercapainya Jangka Waktu Kerja Sama oleh salah satu PIHAK apabila terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) PERJANJIAN ini atau atas keinginan dari salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) PERJANJIAN ini.

PASAL 10 PENGAKHIRAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Kerja sama PARA PIHAK berdasarkan PERJANJIAN ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum berakhirnya Jangka Waktu Kerja Sama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN ini dan tetap tidak memenuhi atau memperbaiki pelanggaran dimaksud setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 15 (lima belas) Hari Kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran PERJANJIAN ini dari PIHAK yang dirugikan yang dikirimkan dengan tenggang waktu minimal 15 (lima belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat teguran/peringatan ke-3 (tiga).
 - b. Dalam hal PIHAK KEDUA pindah ke lokasi yang tidak disepakati secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA. Dalam hal terjadi demikian maka pengakhiran Perjanjian dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan mekanisme surat teguran/peringatan serta surat pemberitahuan pengakhiran sebagaimana ketentuan ayat (1) huruf a Pasal ini.
 - c. Izin usaha PIHAK PERTAMA atau ijin operasional PIHAK KEDUA dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Dalam hal demikian maka Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau izin operasional atau izin praktik PIHAK yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi; dan/atau
 - d. Salah satu PIHAK mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal PIHAK yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku; dan/atau

- e. Salah satu PIHAK dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya putusan pailit oleh Pengadilan.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri PERJANJIAN ini sebelum tercapainya Jangka Waktu Kerja Sama dikarenakan hal-hal selain dari yang disebutkan pada ayat (1) pasal ini, maka PIHAK tersebut wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai maksudnya tersebut disertai dengan alasan yang mendasari sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang diinginkan.
- (3) Sehubungan dengan pengakhiran kerja sama diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/mengakhiri suatu Perjanjian.
- (4) Berakhirnya kerja sama diantara PARA PIHAK karena sebab apapun tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam PERJANJIAN ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya. Jika ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK saat berakhirnya PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK wajib menyelesaikan kewajibannya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya PERJANJIAN ini.

PASAL 11

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Perhitungan tarif Pelayanan Kesehatan yang dibebankan kepada PIHAK PERTAMA didasarkan atas tarif yang telah disepakati bersama yang dituangkan dalam suatu kesepakatan tarif sebagaimana yang diatur dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan yang berlaku dalam kesepakatan adalah tarif pelayanan yang ditetapkan dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- (3) Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan berlaku tetap selama berlangsungnya kerja sama.
- (4) Dalam hal terdapat usulan perubahan tarif yang akan ditawarkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA alasan perubahan disertai penjelasan item perhitungan perubahan tarif selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberlakuan tarif baru dan perubahan Tarif Pelayanan Kesehatan dilaksanakan paling cepat 1 tahun sekali.
- (5) Usulan perubahan tarif tersebut dikirimkan melalui surat pos dan surat elektronik (*e-mail*) kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan alamat korespondensi pada Lampiran VI.
- (6) Perubahan Tarif Pelayanan Kesehatan hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal berkas tagihan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menggunakan tarif di luar dari yang telah disepakati PARA PIHAK, maka berkas tagihan dimaksud akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan pembetulan sebagaimana tarif yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (8) Apabila dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan, PIHAK KEDUA menggunakan Dokter Tamu, maka tarif yang digunakan adalah tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (9) PIHAK KEDUA dilarang memungut biaya tambahan atas Pelayanan Kesehatan dan/atau perawatan dan/atau obat yang diberikan kepada Peserta dalam bentuk apapun di luar dari biaya-biaya yang telah diatur dalam PERJANJIAN ini.

PASAL 12

SISTEM INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Bahwa guna mempercepat proses administrasi pelayanan perawatan dan pengobatan kepada Peserta, serta proses pengesahan (*discharge*) atas perawatan dan pengobatan tersebut beserta

biayanya, PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan dan memberlakukan aplikasi Sistem Integrasi Pelayanan Kesehatan pada sistem informasi layanan masing-masing PIHAK.

- (2) Sehubungan dengan hal pada ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk menambah ketentuan di dalam Perjanjian yang berkenaan dengan:
- a. Penggunaan aplikasi sistem informasi dalam proses administrasi pelayanan Peserta;
 - b. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh PARA PIHAK guna mempercepat proses integrasi dan implementasi sistem; dan
 - c. Ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga data / informasi masing-masing PIHAK dan Peserta yang bersifat rahasia.

PASAL 13

TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN

- (1) Pengajuan tagihan atas biaya Pelayanan Kesehatan dan biaya pelayanan obat Peserta oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan secara elektronik melalui *Front End System* (Sistem Administrasi dan Layanan Kesehatan Peserta atau sistem administrasi yang berjalan saat ini diantara PARA PIHAK), dengan syarat berkas asli tagihan beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana diatur dalam Lampiran V ini dilakukan *batching online* oleh PIHAK KEDUA wajib diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal PIHAK KEDUA mendapatkan *LoC (Letter of Confirmation)* atau penandatanganan surat keluar oleh Peserta/keluarga Peserta dari PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila melebihi batas waktu tersebut maka tagihan/klaim yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dinyatakan kadaluwarsa, dan karenanya PIHAK PERTAMA berhak menolak tagihan serta pembayaran yang diajukan.
- (3) Pengajuan tagihan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilaksanakan dengan tetap memperhatikan batas waktu penyampaian berkas asli tagihan sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini.
- (4) Berkas tagihan *softcopy* di unggah pada *Front End System* dan berkas dokumen *hardcopy* dikirim kepada PIHAK PERTAMA, sebagaimana diatur dalam Lampiran V.
- (5) Pada saat pengiriman tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, PIHAK KEDUA wajib mengirimkan list rekapitulasi tagihan atas dokumen tagihan yang diajukan. Dalam hal terdapat data dalam list rekapitulasi tagihan tidak sesuai dengan data dalam dokumen tagihan maka PIHAK PERTAMA akan mengklarifikasi dengan PIHAK KEDUA guna memastikan data yang sebenarnya.
- (6) Apabila terdapat ketidaksesuaian data atau berkas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, maka:
 - a. Dalam hal ketidaksesuaian pada dokumen atau berkas asli, maka PIHAK KEDUA wajib mengirimkan berkas asli yang sebenarnya, dan PIHAK PERTAMA akan mengembalikan berkas asli yang tidak sesuai tersebut kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Dalam hal ketidaksesuaian pada dokumen fotokopi, maka PIHAK KEDUA dapat mengirimkan fotokopi dokumen tersebut kepada PIHAK PERTAMA melalui *Front End System*.
- (7) Terhadap Pelayanan Kesehatan ASO, tata cara pengajuan klaim atau tagihan mengacu pada Perjanjian ASO.
- (8) PIHAK PERTAMA berhak melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap tagihan yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal berkas tagihan yang disampaikan tidak atau belum memenuhi persyaratan atau belum lengkap dan/atau PIHAK PERTAMA menemukan adanya kekeliruan atau penyimpangan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak pembayaran tagihan serta meminta PIHAK KEDUA untuk melengkapi dan/atau memperbaiki tagihannya, dan atas hal tersebut PIHAK KEDUA wajib untuk segera melengkapi dan/atau memperbaiki berkas tagihan dan mengirimkannya kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah menerima pemberitahuan di dalam sistem (Sistem Administrasi dan Layanan Kesehatan Peserta atau sistem administrasi yang berjalan saat ini diantara PARA PIHAK) atau

melalui sarana komunikasi lainnya yang digunakan PARA PIHAK dalam Pelayanan Kesehatan dan/atau Penagihan apabila sistem dimaksud pada PIHAK KEDUA tidak atau belum tersedia.

- (3) Setiap tagihan yang ditolak harus disampaikan secara tertulis beserta alasan penolakannya.
- (9) Dalam hal PERJANJIAN ini berakhir dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK, maka tagihan terakhir dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA wajib diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya PERJANJIAN ini.
- (10) Apabila PIHAK PERTAMA telah melakukan pembayaran dan di kemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran tagihan kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada PIHAK PERTAMA dengan cara dan waktu pengembalian yang disepakati PARA PIHAK, dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak kelebihan pembayaran tersebut diberitahukan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 14 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya Pelayanan Kesehatan dan biaya Pelayanan Obat oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal PIHAK PERTAMA telah menerima secara lengkap tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan proses verifikasi selesai dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Setelah hasil verifikasi diterima PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib mengirimkan berkas salinan fisik (*hard copy*) tagihan secara lengkap sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) kepada PIHAK PERTAMA dan diterima paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal terbit Surat Jalan (SJL) atau *Transaction Verification Form* (TVF).
- (3) PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan berkas tagihan ke PIHAK KEDUA apabila tarif dan berkas tagihan tidak sesuai dengan ketentuan.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang timbul oleh karena PIHAK KEDUA memberikan fasilitas dan/atau Pelayanan Kesehatan serta Pelayanan Obat kepada Peserta yang tidak termasuk ke dalam fasilitas dan/atau Pelayanan Kesehatan yang menjadi hak Peserta berdasarkan Produk yang dipilihnya.
- (5) Pembayaran biaya Pelayanan Kesehatan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui transfer/pemindahbukuan ke rekening yang disebutkan di dalam lampiran V.

PASAL 15 PERPAJAKAN

- (1) Pajak-pajak yang timbul akibat dari PERJANJIAN ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK wajib mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia dan segala pajak harus sudah diperhitungkan dalam surat pengajuan kerja sama.
- (3) Masing-masing PIHAK wajib untuk menanggung dan membayar pajak, bea pungutan, dan pembayaran lainnya yang menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini maupun yang mungkin timbul dikemudian hari yang merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 16 PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Setiap perubahan, penambahan, atau pengurangan ketentuan dalam PERJANJIAN ini harus disepakati oleh PARA PIHAK melalui suatu perjanjian perubahan atau tambahan (AMENDEMENT/Adendum) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini. PARA

PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini dapat diubah kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan PARA PIHAK.

- (2) AMENDEMEN/Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PASAL 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perbedaan penafsiran, pendapat, atau perselisihan diantara PARA PIHAK sehubungan dengan isi atau bentuk pelaksanaan dan/atau tidak dilaksanakannya suatu ketentuan dalam Perjanjian, maka PARA PIHAK wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat/kesepakatan penyelesaian.
- (2) Jangka waktu musyawarah untuk mencapai mufakat dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah selama 60 (enam puluh) Hari Kealender terhitung sejak tanggal dimulainya musyawarah diantara PARA PIHAK atau dalam jangka waktu lain yang disepakati PARA PIHAK dalam musyawarah tersebut ("Jangka Waktu Musyawarah"), dan selama Jangka Waktu Musyawarah PARA PIHAK wajib merahasiakan hal tersebut kecuali diantara PARA PIHAK saja.
- (3) Apabila selama Jangka Waktu Musyawarah tidak diperoleh kesepakatan penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian melalui Pengadilan yang berwenang, dan untuk itu PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- (4) Segala biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing PIHAK sehubungan penyelesaian perselisihan baik yang dilakukan melalui musyawarah maupun melalui Pengadilan menjadi beban dan tanggungan masing-masing.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk tetap melaksanakan terus semua ketentuan dalam PERJANJIAN ini dan tidak berhak untuk memulai atau mempertahankan suatu tindakan di hadapan Pengadilan mengenai suatu hal yang masih dalam perselisihan sampai hal tersebut diajukan dan diputuskan sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) Pasal ini, kecuali dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sesuai dengan yang diatur dalam PERJANJIAN ini.

PASAL 18

PERIZINAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib memastikan dan menjamin bahwa seluruh Perizinan yang diperlukan untuk Pelaksanaan Penyedia layanan Kesehatan telah didapat sebelum tanggal dimulai berlakunya PERJANJIAN ini.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memastikan keberlakuan dan perpanjangan seluruh Perizinan yang diperlukan untuk pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- (3) PIHAK KEDUA menanggung seluruh biaya yang timbul untuk mendapatkan dan/atau memperpanjang jangka waktu setiap Perizinan.
- (4) Bila dalam pengurusan Perizinan tersebut diperlukan surat dukungan dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan membantu memberikan surat dukungan/referensi yang berkaitan dengan keterangan pekerjaan tersebut sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Peraturan Internal PIHAK PERTAMA.
- (5) Surat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini harus digunakan sesuai peruntukannya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian, dan apabila PIHAK KEDUA menggunakan selain peruntukan terkait pelaksanaan Perjanjian maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan Pengakhiran dan Pemutusan Kerja Sama sesuai ketentuan Pasal 10 PERJANJIAN ini.

PASAL 19
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (2) Apabila keadaan memaksa/*Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Kerja Sama ini.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PASAL 20
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) Dalam kaitannya dengan PERJANJIAN ini dan pelaksanaannya oleh PARA PIHAK berkenaan dengan Perlindungan Data Pribadi Peserta Asuransi maupun Peserta Layanan Jasa lainnya dari PIHAK PERTAMA berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. PARA PIHAK wajib mematuhi serta memenuhi setiap kewajiban yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berikut dengan peraturan pelaksanaannya, termasuk pada yang akan ada dikemudian hari.
 - b. Penggunaan, penyimpanan dan pengungkapan data pribadi oleh masing-masing PIHAK dilakukan hanya sebatas dan semata-mata dalam rangka pelaksanaan PERJANJIAN ini.
 - c. Tanpa adanya persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA dan/atau Pemilik Data Pribadi, PIHAK KEDUA dengan cara dan bentuk apapun tidak diperkenan untuk menyalin, mengalihkan membagikan, ataupun mengungkapkan data pribadi milik Peserta dimaksud, baik yang diterima dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK lain yang memiliki Kerja Sama dengan PIHAK PERTAMA, baik untuk kepentingan PIHAK KEDUA sendiri maupun kepentingan PIHAK KEDUA manapun juga.
- (2) Sehubungan dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini:
 - a. Masing-masing Pihak wajib memiliki dan menerapkan:
 - i. Sistem Perlindungan Data pada Sistem Aplikasi yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan PERJANJIAN ini; dan
 - ii. Prosedur Standar yang diberlakukan guna mencegah terjadinya kebocoran, pengambilalihan, penyalinan atau penggandaan data-data oleh PIHAK lain manapun yang tidak berkepentingan dengan data-data yang ada pada Sistem Aplikasi dimaksud.
 - b. Masing-masing Pihak berkewajiban untuk:
 - i. Menetapkan karyawannya masing-masing yang ditugaskan untuk mengelola dan menjalankan Sistem Aplikasi yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan PERJANJIAN ini;
 - ii. Memastikan hanya karyawan-karyawan yang ditugaskan tersebut yang dapat mengakses dan menjalankan Sistem Aplikasi; dan
 - iii. Memastikan bahwa karyawan-karyawan tersebut mematuhi Prosedur Standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a butir ii pada Pasal ini, dan ketentuan

Perundang-undangan mengenai Perlindungan Data Pribadi, dalam hal ini adalah Data Pribadi milik Peserta maupun yang dimiliki oleh masing-masing Pihak.

- (3) Pelanggaran oleh karyawan atas ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pada Pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Pihak yang diwakilinya.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK melakukan pelanggaran, dan karena pelanggaran tersebut PIHAK lainnya dalam PERJANJIAN ini mendapatkan tuntutan hukum dan/atau termasuk dihukum dan diharuskan untuk membayar ganti rugi, maka PIHAK yang melakukan Pelanggaran wajib dan bersedia menanggung serta membayarkan seluruh biaya-biaya yang diperlukan untuk itu termasuk atas jumlah nilai ganti rugi yang secara hukum harus dibayarkan oleh Pihak yang dihukum kepada Pihak yang dirugikan.

PASAL 21 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email dan/atau faksimile, dan dikirimkan ke alamat sebagaimana terdapat dalam Lampiran VI, atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis.
- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui email dianggap telah diterima pada saat email tersebut dikonfirmasi diterima, pengiriman melalui *telex* atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman *telex* dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

PASAL 22 INTEGRITAS DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

- (1) Sehubungan dengan Perjanjian dan hal-hal, dokumen-dokumen, kegiatan-kegiatan, dan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam atau terkait dengan PERJANJIAN ini PARA PIHAK menyepakati tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, penggelapan, pemerasan, kolusi, penyuapan, gratifikasi, korupsi, kecurangan, pemalsuan sebagaimana Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan etika bisnis yang baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Persyaratan Hukum dan peraturan yang mengatur mengenai tata kelola anti penyuapan yang berlaku di lingkungan masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menyepakati bahwa PERJANJIAN ini dilaksanakan dengan itikad baik, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya, menerima serta bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, menghindari serta mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*), menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- (3) PARA PIHAK menyatakan, menjamin dan berkomitmen bahwa dalam melaksanakan Perjanjian akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Persyaratan

Hukum terkait anti korupsi, anti pencucian uang serta kebijakan PARA PIHAK mengenai anti-fraud dan tata kelola anti-penyuapan seperti:

- a. Menerapkan 4 no's:
 - i. *No bribery*, menghindari suap menyuap dan pemerasan.
 - ii. *No gift*, menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
 - iii. *No kickback*, menghindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya.
 - iv. *No luxurious hospitality*, menghindari jamuan yang berlebihan.
 - b. Mengikuti prosedur uji kelayakan berbasis integritas (*integrity due diligence*) yang diterapkan PARA PIHAK;
 - c. Melaporkan insiden *Fraud* melalui *whistle blowing system*.
- (4) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), jika dalam proses pelaksanaan PERJANJIAN ini PARA PIHAK mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, konflik kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PARA PIHAK, agar melaporkan melalui *whistle blowing system* email laporpelanggaran@plninsurance.co.id form *whistle blowing system* pada website www.plninsurance.co.id atau media *whistle blowing system* lainnya yang dapat ditentukan oleh PARA PIHAK dari waktu ke waktu.
- (5) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan Pasal ini, maka Surat Pengakhiran Perjanjian akan diberikan sejak diberitahukannya pelanggaran tersebut tanpa menghapuskan kewajiban-kewajiban dari kedua belah PIHAK yang belum terselesaikan.

PASAL 23

KEAMANAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan mentaati Peraturan Perundang-Undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan Lokasi kegiatan, keselamatan Peserta, kebersihan lingkungan, alat-alat dan material untuk Pelaksanaan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan, sejauh hal tersebut berada dalam Wewenang dan Pengawasan PIHAK KEDUA. Tanggung jawab PIHAK KEDUA atas kerugian yang timbul di tempat pekerjaan terbatas pada kerugian yang diakibatkan langsung tindakan atau kelalaian orang-orang yang dipekerjakannya, dengan pengecualian terhadap kerugian yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA, keadaan di luar kendali PIHAK KEDUA atau Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan wajib menyediakan sarana untuk menjaga dan menjamin keselamatan serta keamanan pekerja, guna menghindarkan bahaya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan.
- (4) Jika para petugas/karyawan PIHAK KEDUA mengalami kecelakaan dalam melaksanakan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan ini, maka hal itu merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan wajib melapor ke instansi setempat yang terkait/berwenang, dengan menyampaikan tembusannya ke PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian akibat Kecelakaan Kerja yang dialami PIHAK KEDUA.
- (6) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya Kecelakaan Kerja atau Sertifikasi Kompetensi, maka PIHAK KEDUA akan diberikan teguran sebanyak 2 (dua) kali, yang apabila teguran tersebut tidak ditindaklanjuti dapat mengakibatkan pengenaan sanksi pemutusan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Black List*) di lingkungan PIHAK PERTAMA.

PASAL 24 STANDAR MUTU DAN KUALITAS

Layanan yang harus disediakan dan diserahkan di PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan Peserta dalam konteks Pelayanan Kesehatan adalah dalam keadaan baik, siap pakai, dan memenuhi standar kelaikan yang berlaku.

PASAL 25 KERAHASIAAN DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Istilah "**Informasi Rahasia**" berarti setiap informasi yang diungkapkan oleh Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerima dalam rangka pelaksanaan Perjanjian, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, atau melalui pemeriksaan benda berwujud (termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen, purwarupa, sampel, perangkat lunak, skema, diagram alur, tata letak dan deskripsi grafis, pabrik dan peralatan, termasuk juga informasi / data pribadi seseorang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang ditetapkan sebagai "**Rahasia**".
- (2) Informasi yang dikomunikasikan secara lisan atau visual akan dianggap sebagai Informasi Rahasia, jika informasi tersebut dikonfirmasi secara tertulis sebagai Informasi Rahasia dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah pengungkapan awal.
- (3) Tidak ada Pihak yang akan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain, mengungkapkan Informasi Rahasia apa pun kepada orang lain selain kepada pemegang saham yang relevan, komisaris, direktur, dan karyawan, yang tentunya diwajibkan dalam menjalankan tugasnya untuk menerima dan mempertimbangkan hal yang sama untuk keperluan PERJANJIAN ini ("**Perwakilan**"). Para Pihak harus memastikan bahwa perwakilannya kepada siapa Informasi Rahasia diungkapkan harus mematuhi ketentuan-ketentuan PERJANJIAN ini dalam segala hal seolah-olah mereka adalah Pihak untuk itu dan masing-masing Pihak akan bertanggung jawab atas pelanggaran salah satu ketentuan PERJANJIAN ini oleh orang-orang tersebut seolah-olah itu adalah Pihak yang telah melanggar istilah itu.
- (4) Informasi Rahasia tidak akan mencakup informasi apa pun yang:
 - a. merupakan informasi di ranah publik pada saat Informasi Rahasia itu diungkapkan atau telah masuk ke dalam ranah publik bukan akibat kesalahan Pihak Penerima;
 - b. telah diketahui oleh Pihak Penerima, tanpa batasan, pada saat pengungkapan, sebagaimana ditunjukkan oleh *file* yang sudah ada pada saat pengungkapan;
 - c. telah diperoleh dengan semestinya oleh Pihak Penerima dari PIHAK KEDUA yang secara sah memiliki informasi tersebut dan tanpa melanggar kewajiban kerahasiaan PIHAK KEDUA tersebut; atau
 - d. telah diperintahkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, kebijakan atau dalam proses pengadilan, arbitrase atau pemerintah atau penyelidikan, dengan ketentuan, bahwa (i) Pihak Pengungkap telah diberi pemberitahuan yang wajar sebelumnya untuk memungkinkannya mengambil tindakan untuk melindungi kepentingannya dan Pihak Penerima harus bekerja sama terkait semua permintaan wajar dari Pihak Pengungkap sehubungan dengan hal tersebut, termasuk setiap perintah perlindungan atau bentuk perlindungan lain yang dimohonkan oleh Pihak Pengungkap dan (ii) Pihak Penerima hanya mengungkapkan bahwa sebagian dari Informasi Rahasia (dengan salinan lengkap yang disampaikan kepada Pihak Pengungkap) yang harus diungkapkan dan akan menjaga kerahasiaan semua Informasi Rahasia lain.
- (5) Pihak Penerima setuju untuk tidak menggunakan Informasi Rahasia dari Pihak Pengungkap untuk tujuan apa pun selain untuk mengevaluasi dan ikut serta dalam pembahasan mengenai pelaksanaan PERJANJIAN ini antara PARA PIHAK.
- (6) Pihak Penerima tidak bisa menyalin, mereproduksi, menggandakan, mengkompilasi, mengubah, mengedit, memisahkan atau merekayasa balik setiap sampel dari Pihak Pengungkap dan/atau benda berwujud yang berisi Informasi Rahasia, dan tidak membuat setiap PIHAK KEDUA untuk

melakukan hal yang sama. Pihak Penerima setuju untuk tidak mendistribusikan, menawarkan untuk menjual, menjual, mengirim, atau mengalihkan sampel milik Pihak Pengungkap kepada PIHAK KEDUA.

- (7) Semua Informasi Rahasia akan tetap merupakan milik eksklusif Pihak Pengungkap dan tidak ada hal apa pun dalam PERJANJIAN ini, atau tindakan apa pun di antara PARA PIHAK, yang akan dianggap memberikan kepada Pihak Penerima suatu lisensi, hak, kepemilikan atau kepentingan dalam atau pada Informasi Rahasia (kecuali disetujui lain secara tertulis oleh PARA PIHAK). Pihak Penerima tidak memperoleh lisensi atau hak kekayaan intelektual apapun berdasarkan PERJANJIAN ini, kecuali hak terbatas untuk meninjau Informasi Rahasia tersebut untuk mengevaluasi hubungan bisnis dan, jika berlaku, kinerja hubungan bisnis tersebut.
- (8) Dalam hal terjadinya penghentian PERJANJIAN ini, Pihak Penerima akan mengembalikan atau memusnahkan Informasi Rahasia dan setiap reproduksinya apabila pengembalian atau pemusnahan tersebut tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Dalam hal Pihak Penerima memilih untuk memusnahkan Informasi Rahasia, maka Pihak Penerima harus membuat surat pernyataan dan menyampaikan kepada Pihak Pengungkap bahwa Pihak Penerima telah memusnahkan Informasi Rahasia tersebut.
- (9) Terlepas dari hal tersebut di atas, Pihak Penerima dan Perwakilannya dapat menyimpan (dengan tunduk pada ketentuan PERJANJIAN ini) salinan Informasi Rahasia, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pihak Pengungkap, sepanjang penyimpanan tersebut diwajibkan dalam melaksanakan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan regulasi yang berlaku, asalkan salinan Informasi Rahasia harus tetap dirahasiakan dan tidak digunakan oleh Pihak Penerima dan Perwakilannya dalam situasi tersebut.
- (10) Kewajiban kerahasiaan berdasarkan Pasal ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya atau pengakhiran PERJANJIAN ini.

PASAL 26 SANKSI

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti secara nyata melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melayani Peserta sesuai dengan kewajibannya sebagai Provider; dan/atau
 - b. Tidak memberikan fasilitas dan Pelayanan Kesehatan serta Pelayanan Obat kepada Peserta sesuai dengan haknya berdasarkan Plan yang dipilihnya; dan/atau
 - c. Memungut biaya tambahan kepada Peserta di luar kesepakatan yang ada.maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menagguhkan pembayaran atas tagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA, sampai adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan tindakan atau kesalahan atau malpraktik yang menimbulkan kerugian bagi Peserta sehingga mengakibatkan Peserta menuntut PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA wajib mengganti kerugian dan menghadapi tuntutan yang diajukan oleh Peserta.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PERJANJIAN ini padahal PIHAK PERTAMA telah menyetujui tagihan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran minimal 15 (lima belas) Hari Kalender. Apabila surat teguran ketiga tidak mendapatkan tanggapan dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berhak mengakhiri dan memutuskan kerja sama ini berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a PERJANJIAN ini.

**PASAL 27
LAIN-LAIN**

- (1) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan Pelayanan Kesehatan dari PIHAK KEDUA kepada Peserta yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar syarat dan ketentuan dalam PERJANJIAN ini dan terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh Peserta kepada PIHAK KEDUA yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam menjalankan tanggung jawab profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan dalam memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan tindakan medis.
- (2) Kegagalan atau keterlambatan dari suatu PIHAK untuk menggunakan sesuatu hak, atau kekuasaan berdasarkan PERJANJIAN ini tidak berarti bahwa PIHAK tersebut telah melepaskan hak-hak dimaksud, demikian juga pelaksanaan satu persatu atau sebagian dari hak yang terlambat digunakan tersebut tidak akan menghalanginya untuk meminta serta mendapatkan pelaksanaan dari hak-hak lainnya yang sudah ada/timbul dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
- (3) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam PERJANJIAN ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa ketentuan lainnya dalam PERJANJIAN ini tidak akan terpengaruh olehnya, tetap sah, berlaku dan dapat dilaksanakan.
- (4) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam PERJANJIAN ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.
- (5) PERJANJIAN ini beserta ketentuan-ketentuan yang dimuat didalamnya dan di dalam lampiran-lampiran menggantikan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PERJANJIAN terhitung sejak tanggal dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana disebutkan pada bagian awal PERJANJIAN ini dan terhadap ketentuan Tarif Kesepakatan dan/atau Hak Istimewa (*Privilege*) kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimuat dalam LAMPIRAN IV berlaku mulai tanggal yang disebutkan didalamnya.

Demikianlah, PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh wakil-wakil dari PARA PIHAK pada tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal PERJANJIAN ini dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
PT ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL

PIHAK KEDUA
PT DISA PRIMA MEDIKA

Moch. Hirmas Fuady
Presiden Direktur

dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur Utama

LAMPIRAN I

ISTILAH DAN PENGERTIAN

Merujuk ketentuan Pasal 1 ayat (1) PERJANJIAN ini, istilah yang digunakan dalam Perjanjian beserta pengertiannya, sebagai berikut:

- (1) **Pelayanan Kesehatan** adalah fasilitas kesehatan berupa kegiatan promotif, kegiatan preventif, kegiatan kuratif dan kegiatan rehabilitatif Peserta.
- (2) **Asuransi** adalah asuransi kesehatan *Managed Care Plus* dan *Indemnity*.
- (3) **Managed Care Plus** adalah salah satu jenis Produk Asuransi Kesehatan di PIHAK PERTAMA yang menerapkan konsep *Managed Care*, yaitu sistem layanan kesehatan yang mengintegrasikan pembiayaan dan penyediaan perawatan kesehatan dalam suatu sistem pengelolaan biaya dengan kesepakatan tarif untuk memaksimalkan layanan kesehatan dari nilai manfaat yang diterima bertanggung. Menerapkan rujukan berjenjang mulai dari tingkatan Klinik hingga Rumah Sakit, bertujuan memberikan layanan kesehatan berkualitas dengan biaya yang terkendali atau terpantau, dan merekomendasikan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pembiayaan menjadi efisien dan efektif atau tepat sasaran.
- (4) **Indemnity** adalah skema jaminan kesehatan yang lebih menekankan pada batasan biaya jaminan kesehatan, Peserta mempunyai kebebasan memilih Dokter untuk konsultasi, dapat langsung ke Dokter Umum, Dokter Spesialis maupun Laboratorium tanpa memerlukan surat rekomendasi dan tidak ada pembatasan daftar obat dan pembatasan RS untuk berobat selama masih dalam jaringan PIHAK KEDUA yang ditentukan.
- (5) **Administration Service Only** disingkat **ASO** adalah jasa layanan pengelolaan administrasi dari dana pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian jasa layanan ASO.
- (6) **Peserta** adalah Peserta Asuransi atau Peserta ASO pada PIHAK PERTAMA yang terdaftar secara resmi dan namanya termuat pada *System Front End* yang dibuktikan pada kartu peserta atau *e-card* PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, atau melalui media lainnya dari PIHAK PERTAMA.
- (7) **Kartu Peserta** adalah kartu identitas Peserta yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai bukti yang sah dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan.
- (8) **E-Card (Kartu Kesehatan Jaringan Elektronik)** adalah kartu kesehatan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dan diberikan kepada Peserta sebagai identitas kepesertaan pada asuransi kesehatan Provider yang digunakan sebagai kemudahan akses pada seluruh Pesertanya sehingga pembiayaan tersebut menjadi efisien dan efektif atau tepat sasaran.
- (9) **Quick Response Code (QR Code)** adalah salah satu jenis barcode yang dapat di baca dengan mudah oleh perangkat digital.
- (10) **Polis** adalah dokumen Perjanjian Asuransi antara PIHAK PERTAMA dengan perusahaan Peserta Asuransi Kesehatan yang berisi Syarat Umum Polis dan atau Ketentuan Tambahan (Addendum) dan atau Catatan Tambahan (*Endorsement*) dan atau Lampiran dan atau lainnya yang termasuk dokumen Peserta yang dipertanggungjawabkan yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA yang keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
- (11) **Provider** adalah suatu Institusi/Lembaga Pelayanan Kesehatan yang mempunyai ijin resmi dan terdaftar, dimana mempunyai Perjanjian Kerja Sama dengan PIHAK PERTAMA untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta, dalam hal ini adalah Rumah Sakit.
- (12) **Rumah Sakit** adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan berbagai layanan medis untuk pasien, mulai dari rawat jalan, rawat inap, hingga layanan gawat darurat. Selain itu, rumah sakit juga berperan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta pusat penelitian medis.
- (13) **Provider Tingkat Pertama atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)** adalah sarana Pelayanan Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan umum yang menyeluruh, dan mengutamakan pelayanan Promotif dan Preventif.

- (14) **Provider Tingkat Lanjutan atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)** adalah sarana Pelayanan Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Spesialis dan Subspesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya.
- (15) **Non Provider** adalah suatu Institusi/Lembaga Pelayanan Kesehatan yang mempunyai ijin resmi dan terdaftar, akan tetapi tidak mempunyai Perjanjian Kerja Sama dengan PIHAK PERTAMA.
- (16) **Sistem Pelayanan** yang diberikan terdapat 2 (dua) cara, yaitu antara lain:
- Sistem Provider (*Cashless*)**
Sistem pelayanan yang diberikan berupa Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan jaringan provider, dimana Peserta yang memerlukan Pelayanan Kesehatan wajib memperlihatkan Kartu Peserta yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA secara sah dan masih berlaku, yang menjelaskan jenis pelayanan dan tarif kesehatan yang harus diberikan kepada Peserta, dan Peserta dibebaskan dari kewajiban membayar uang jaminan atau uang muka untuk Pelayanan Kesehatan sesuai dengan batasan manfaat asuransi.
 - Sistem Non Provider (*Restitusi/ Reimbursement*)**
Sistem pelayanan ini tidak menggunakan pelayanan jaringan Provider dimana Peserta yang memerlukan Pelayanan Kesehatan tanpa memperlihatkan Kartu Peserta, selanjutnya Peserta harus membayar terlebih dahulu atas seluruh biaya yang dikeluarkan dan kemudian mengajukan klaim untuk penggantian biaya tersebut kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan *benefit* dan tarif dengan menggunakan dokumen-dokumen asli yang telah dipersyaratkan.
- (15) **Kelas Perawatan** adalah fasilitas Rawat Inap yang menjadi hak Peserta sesuai dengan yang tercantum pada Kartu Peserta.
- (16) **Rawat Jalan** adalah pemeliharaan/Pelayanan Kesehatan dasar/esensial yang diberikan oleh dokter umum berupa jasa medis dan/atau obat serta tindakan medis lainnya termasuk pemeliharaan/Pelayanan Kesehatan rujukan/spesialistik berupa jasa/tindakan medis spesialistik, obat dan pemeriksaan penunjang diagnosa.
- (17) **Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)** adalah Pelayanan Kesehatan perorangan yang dilakukan oleh Dokter Umum, Dokter Gigi atau pada Klinik 24 jam, dengan atau tanpa obat dan tidak sedang menjalani Rawat Inap.
- (18) **Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)** adalah Pelayanan Kesehatan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik tanpa menginap di ruangan perawatan dan dilaksanakan pada Provider Tingkat Lanjutan sebagai rujukan dari Provider Tingkat Pertama.
- (19) **Rawat Inap (RI)** adalah pelayanan yang bersifat spesialistik/subspesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, yang dilaksanakan di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dimana Peserta di Rawat Inap di ruang perawatan paling sedikit 1 (satu) hari.
- (20) **Rawat Gigi** mencakup Pelayanan Medik Gigi Dasar/ Rawat Gigi Tingkat Pertama dan Pelayanan Medik Gigi Spesialistik/ Rawat Gigi Tingkat Lanjutan.
- (21) **Pelayanan Medik Gigi Dasar / Rawat Gigi Tingkat Pertama (RGTP)** adalah kegiatan pelayanan gigi dan mulut perorangan dan keluarga yang meliputi aspek pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier, yang dilaksanakan tenaga profesional kesehatan gigi dan mulut, baik berupa tindakan kompleks maupun sederhana, sesuai dengan standar yang berlaku.
- (22) **Pelayanan Medik Gigi Spesialistik / Rawat Gigi Tingkat Lanjutan (RGTL)** adalah kegiatan pelayanan gigi dan mulut perorangan dan keluarga yang diberikan oleh tenaga kedokteran gigi sesuai dengan bidang gigi spesialistik yang diakui oleh profesi kedokteran gigi dan sesuai standar yang berlaku.
- (23) **Rawat Bersalin (Maternity)** adalah kegiatan selama proses kehamilan hingga persalinan, termasuk pemeriksaan rutin, biaya persalinan, dan penanganan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (24) **Formularium Obat (FO)** adalah formularium obat yang diberlakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam pelayanan obat-obatan oleh PIHAK KEDUA kepada Peserta *Managed Care Plus* dan *Indemnity*.
- (25) **Daftar Obat** adalah daftar lengkap atau katalog obat-obatan yang tersedia untuk penggunaan medis. Daftar ini mencakup informasi tentang setiap obat, termasuk nama generik dan nama merek, dosis yang direkomendasikan, bentuk sediaan (misalnya tablet, kapsul, cairan), dan informasi lain yang relevan seperti kontraindikasi, efek samping, dan interaksi obat.
- (26) **Obat-obatan yang diresepkan** adalah obat-obatan yang terdaftar dalam daftar obat Indonesia yang sesuai dengan Daftar Obat Standar PIHAK PERTAMA dan bukan digolongkan sebagai obat suplemen atau multi vitamin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang diberikan oleh Dokter atau dibeli di Instalasi Farmasi atau Apotek yang memiliki Apoteker serta memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Instansi Berwenang, sehubungan dengan perawatan atas ketidakmampuan secara fisik yang dijamin oleh PIHAK PERTAMA.
- (27) **Alat kesehatan** adalah suplemen yang diberikan kepada Peserta seperti kacamata, alat bantu dengar, gigi tiruan, alat gerak tiruan, implant (*IOL, plat, pen, screw, K-Wire* dan *implant* lain).
- (28) **Pemeriksaan Penunjang** adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosa penyakit dengan tepat/memastikan penegakan diagnosa sebelum dilakukan tindakan operasi atau untuk mengevaluasi hasil perawatan terhadap suatu penyakit.
- (29) **Instalasi Gawat Darurat (IGD)** adalah Pelayanan Kesehatan yang memberikan penanganan awal pada kasus-kasus gawat darurat atau membutuhkan tindakan medis segera bagi Peserta dengan penyakit atau cedera yang dapat mengancam hidup, untuk penyelamatan nyawa atau mengurangi resiko kematian dan pencegahan kecacatan.
- (30) **Medical Check Up** adalah pemeriksaan medis sebagai langkah preventif untuk mengetahui secara dini tentang keadaan/kondisi kesehatannya.
- (31) **Pelayanan Satu Hari (One Day Care atau ODC)** adalah pelayanan yang dilakukan tindakan pembedahan atau perawatan darurat di IGD terhadap kondisi penyakit tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dengan atau tanpa anestesi dimana Peserta dapat langsung pulang tanpa harus Rawat Inap dengan lama pelayanan di rumah sakit maksimal 8 jam.
- (32) **Surat Jaminan Pelayanan (SJP)** adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dan diberikan kepada Peserta PIHAK PERTAMA sebagai jaminan untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit tersebut.
- (33) **Surat Rujukan** adalah Surat yang dikeluarkan oleh seorang Dokter Umum kepada Dokter Spesialis dan Dokter lain dan atau salah satu Jaringan Rumah Sakit terhadap Rumah Sakit Lain karena satu dan lain hal sehingga Dokter dan atau Rumah Sakit tersebut tidak dapat memberikan Pelayanan Kesehatan yang diperlukan oleh Peserta.
- (34) **Medical Advisory Board (MAB)** adalah sebuah tim dibentuk oleh PIHAK PERTAMA yang terdiri dari Dokter Koordinator atau *Medical Advisor* yang berwenang untuk memberikan masukan, pertimbangan, dan saran dalam bidang medis kepada PIHAK PERTAMA secara kolegal terkait penyelenggaraan sistem Pelayanan Kesehatan berdasar kompetensi, sudut pandang medis, dan ketentuan/perundang-undangan yang berlaku di bidang medis.
- (35) **Diskon** adalah Potongan harga atau pengurangan biaya yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada peserta yang membayar menggunakan asuransi kesehatan tertentu. Diskon ini biasanya merupakan hasil kerja sama antara PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.
- (36) **Hak Istimewa (Privilege)** merujuk pada keistimewaan atau otorisasi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan Layanan Medis dan Non Medis kepada Peserta yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA. Dalam konteks ini, PIHAK KEDUA yang memiliki status "Provider Rekanan" dengan PIHAK PERTAMA.
- (37) **Harga Netto Apotik atau "HNA"** adalah harga dasar obat yang ditetapkan oleh Distributor dan menjadi acuan bagi PIHAK PERTAMA untuk menentukan Harga Jual Apotik atas obat-obatan yang dipergunakan Peserta PIHAK PERTAMA.
- (38) **Lounge** adalah ruang tunggu di Lokasi PIHAK KEDUA yang diperuntukan bagi Peserta PIHAK PERTAMA.

- (39) **Pengecualian** adalah Pelayanan Kesehatan, tindakan atau jenis penyakit dan manfaat asuransinya yang tidak dijamin oleh PIHAK PERTAMA.
- (40) **Kredensialing** adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap Penyedia Layanan Kesehatan yang akan membuka kerja sama dengan PIHAK PERTAMA melalui kriteria-kriteria seleksi yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (41) **Rekredensialing** adalah proses Kredensialing ulang terhadap PIHAK KEDUA yang sebelumnya sudah bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA.
- (42) **Force Majeure** adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam PERJANJIAN ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- (43) **Hari Kalender** adalah tiap-tiap hari termasuk hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (44) **Hari Kerja** adalah hari yang digunakan untuk bekerja kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (45) **Tarif Pelayanan Kesehatan** adalah tarif yang disepakati oleh PARA PIHAK berkenaan dengan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta sesuai dengan jenis asuransi atau layanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta.
- (46) **Sistem Integrasi Pelayanan Kesehatan** adalah aplikasi sistem informasi yang digunakan dalam proses pelayanan, pendaftaran, unggah dokumen, monitoring perawatan, tindakan dan pengobatan kepada Peserta yang dilakukan di PIHAK KEDUA, di mana sistem informasi tersebut saling terhubung pada sistem informasi PARA PIHAK mengenai layanan terhadap Peserta.
- (47) **Klaim** adalah uang penggantian yang dibayar PIHAK PERTAMA apabila Peserta mengalami perawatan di Provider PIHAK PERTAMA.
- (48) **Recovery atau Ekses Klaim** adalah sejumlah Biaya Klaim atas Pelayanan Kesehatan yang menjadi tanggung jawab Peserta disebabkan oleh:
- a. Melebihi Batas Maksimum Manfaat.
 - b. Kondisi yang menjadi Pengecualian.
 - c. Di luar Prosedur yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - d. Prosedur Rumah Sakit atau Klinik yang tidak berhubungan Langsung dengan Penyakit atau Luka.
- (45) **Verifikasi klaim** adalah upaya pemeriksaan kelengkapan/kebenaran berkas kelayakan klaim yang diajukan oleh Provider atau Peserta.
- (46) **Front End System** adalah sebuah sistem aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai penghubung transaksi antara PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA untuk pengumpulan data atau transfer data elektronik secara online. *Front End System* ini berisikan informasi-informasi antara lain data Peserta, historikal klaim, rencana perawatan, dan tagihan atas perawatan. *Front End System* tersebut saat ini menggunakan PICA (PLN *Insurance Claim Access*). Apabila ada perubahan PIHAK PERTAMA akan memberitahukan melalui surat kepada PIHAK KEDUA.
- (47) **Batching Online** adalah proses pengelolaan dan pemrosesan kumpulan data klaim atau polis yang dilakukan secara digital dan *real-time*.
- (48) **Surat Pendaftaran/Otorisasi (*Letter of Authorization-LoA*)** adalah slip pengesahan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA mengenai batas manfaat asuransi kesehatan atau kebijakan fasilitas kesehatan perusahaan sesuai dengan hak Peserta dan digunakan sebagai informasi bagi PIHAK KEDUA dan Peserta melakukan dan rawat jalan.
- (49) **Surat Pengesahan (*Letter of Confirmation-LoC*)** adalah slip pengesahan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA mengenai batas manfaat asuransi kesehatan atau kebijakan fasilitas kesehatan perusahaan Peserta sebagai informasi bagi PIHAK KEDUA dan Peserta yang diterbitkan setelah Peserta melakukan pemeriksaan Rawat Jalan.

- (50) **Ekses Klaim** adalah selisih biaya yang timbul antara biaya perawatan di PIHAK KEDUA dengan manfaat asuransi kesehatan atau kebijakan fasilitas kesehatan perusahaan sesuai hak Peserta.
- (51) **Surat Jalan (SJL)** atau ***Transaction Verification Form (TVF)*** adalah dokumen atau formulir yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA yang wajib diisi oleh PIHAK KEDUA yang disertakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan klaim/tagihan atas biaya Pelayanan Kesehatan; digunakan untuk memastikan bahwa semua informasi dan data terkait transaksi asuransi telah diverifikasi dan sesuai dengan ketentuan perusahaan.
- (52) **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan** adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia.
- (53) **Sistem Tarif INA CBG's (Indonesia Case Based Group)** adalah tarif paket Pelayanan Kesehatan yang mencakup seluruh komponen biaya di PIHAK KEDUA, mulai dari pelayanan nonmedis hingga tindakan medis. Dalam sistem Tarif INA CBG's, paket layanan didasarkan pada pengelompokan diagnosis dan prosedur yang dikaitkan dengan biaya pelayanan.
- (54) **COB (Coordination of Benefits) BPJS Kesehatan** selanjutnya disebut **COB**, adalah sebuah pola pembayaran Pelayanan Kesehatan antara PIHAK PERTAMA dan Penyedia Layanan Kesehatan, di mana PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada Penyedia Layanan Kesehatan atas selisih lebih tagihan yang diakibatkan oleh peningkatan Pelayanan Kesehatan di luar ketentuan BPJS Kesehatan yang diberikan kepada Peserta atas kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (55) **Coding BPJS Kesehatan** adalah kegiatan mengubah diagnosis penyakit menjadi kode yang terdiri dari angka dan huruf. *Coding* juga dapat mencakup pengodean tindakan medis yang dilakukan oleh koder berdasarkan rekam medis.
- (56) **Klien** adalah Badan Hukum yang memiliki kerja sama Pelayanan Kesehatan dengan PIHAK KEDUA.

LAMPIRAN II
LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN DAN PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

(1) PELAYANAN PESERTA ASURANSI KESEHATAN *MANAGED CARE PLUS*

a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)

- i. Untuk mendapatkan pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama pada PIHAK KEDUA, Peserta harus membawa dan menunjukkan kartu identitas asli/kartu keluarga/kartu identitas anak/paspor dan Kartu Peserta atau *e-card* saat melakukan pendaftaran;
- ii. PIHAK KEDUA harus memastikan eligibilitas Peserta yang akan melakukan pelayanan kesehatan melalui akses Kartu Peserta atau *e-card* pada *Front End System* PIHAK PERTAMA untuk mencetak *LoA (Letter of Authorization)*. Setelah mendapatkan *LoA (Letter of Authorization)*, maka Peserta berhak untuk mendapatkan pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dari PIHAK KEDUA;
- iii. Apabila pemeriksaan kesehatan pada Rawat Jalan Tingkat Pertama selesai, PIHAK KEDUA wajib mencetak *LoC (Letter of Confirmation)* dan menuliskan diagnosa, serta rincian tagihan Pelayanan Kesehatan sebelum Peserta diperbolehkan meninggalkan Lokasi PIHAK KEDUA dan meminta Peserta yang bersangkutan untuk menandatangani seluruh lembar pengesahan *LoC (Letter of Confirmation)* pada tanggal yang sama dimana Peserta mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan rincian tagihan dimaksud untuk dilampirkan pada saat penagihan kepada PIHAK PERTAMA;
- iv. Pengesahan *LoC (Letter of Confirmation)* yang tidak sesuai dengan tanggal dimana Peserta mendapatkan Pelayanan Kesehatan tidak dapat ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA;
- v. Apabila dari hasil pemeriksaan Dokter Umum PIHAK KEDUA sebagai fasilitas Rawat Jalan Tingkat Pertama Peserta disarankan untuk mendapatkan layanan Dokter Spesialis, maka Dokter Umum PIHAK KEDUA akan memberikan pada Peserta surat rujukan ke pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang merupakan rekanan PIHAK PERTAMA dengan dilengkapi *LoA (Letter of Authorization)* dan *LoC (Letter of Confirmation)*;
- vi. Dalam pemberian Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama, PIHAK KEDUA diharuskan untuk tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada Peserta PIHAK PERTAMA.

b. Rawat jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

- i. Peserta berkewajiban untuk membawa dan menunjukkan Kartu Identitas asli/Kartu Keluarga/Kartu Identitas Anak/Paspor, dan Kartu Peserta atau *e-card* yang masih berlaku kepada Petugas Pendaftaran PIHAK KEDUA;
- ii. Bagi Peserta yang dirujuk untuk mendapatkan Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan pada Dokter Spesialis PIHAK KEDUA, maka Peserta wajib menunjukkan Surat Rujukan, *LoA (Letter of Authorization)*, dan *LoC (Letter of Confirmation)* dari FKTP kepada Petugas Pendaftaran PIHAK KEDUA;
- iii. Petugas Pendaftaran PIHAK KEDUA wajib memastikan eligibilitas Peserta yang berobat sesuai dengan Kartu Peserta atau *e-card* yang ditunjukkan oleh Peserta. Apabila Peserta dengan alasan apapun tidak dapat menunjukan Kartu Peserta atau *e-card* maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai Pasien Umum yang bukan merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA;

- iv. PIHAK PERTAMA melalui Petugas Pendaftaran PIHAK KEDUA berhak melakukan Verifikasi lainnya (selain Kartu Peserta atau *e-card*) untuk menentukan keabsahan identitas Peserta sebagaimana dipersyaratkan dalam Polis Peserta dan/atau Kebijakan Fasilitas Kesehatan Perusahaan Peserta. Jika ditemukan perbedaan data pada proses Verifikasi lanjutan yang dilakukan maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai Pasien Umum yang bukan merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- v. Petugas Pendaftaran PIHAK KEDUA wajib memeriksa Kartu Peserta atau *e-card* dan hak Peserta dengan melakukan Validasi melalui *Front End System* dan petugas pendaftaran PIHAK KEDUA mencetak *LoA (Letter of Authorization)*, yang dapat berisi penolakan atau persetujuan;
- vi. Jika *LoA (Letter of Authorization)* berisi persetujuan, selanjutnya Peserta akan menerima Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- vii. Jika *LoA (Letter of Authorization)* berisikan penolakan, maka Peserta akan menerima Pelayanan Kesehatan sebagai Pasien Umum yang berlaku di PIHAK KEDUA. Kecuali ditentukan lain sesuai informasi yang tercantum dalam *LoA (Letter of Authorization)*;

c. Rawat Gigi Tingkat Pertama (RGTP)

- i. Pelayanan Medik Gigi Dasar di Poli Gigi PIHAK PERTAMA dapat menerima Peserta dengan jadwal sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, di mana Dokter Gigi Umum dapat memberikan Surat Rujukan untuk Dokter Gigi Spesialis;
- ii. Untuk mendapatkan Pelayanan Medik Gigi Dasar pada Poli Gigi PIHAK PERTAMA, Peserta harus membawa dan menunjukkan Kartu Identitas asli/Kartu Keluarga/Kartu Identitas Anak/Paspor, dan Kartu Peserta atau *e-card* kepada Poli Gigi PIHAK PERTAMA saat melakukan pendaftaran;
- iii. PIHAK PERTAMA harus memastikan eligibilitas Peserta yang akan melakukan pemeliharaan kesehatan melalui akses Kartu Peserta atau *e-card* pada *Front End System* untuk mencetak *LoA (Letter of Authorization)*. Setelah mendapatkan *LoA (Letter of Authorization)*, maka Peserta berhak untuk mendapatkan Pelayanan Medik Gigi Dasar dari Poli Gigi PIHAK PERTAMA;
- iv. Apabila pemeriksaan kesehatan pada Pelayanan Medik Gigi Dasar selesai, PIHAK PERTAMA wajib mencetak *LoC (Letter of Confirmation)* dan menuliskan diagnosa, serta rincian tagihan pelayanan kesehatan sebelum Peserta diperbolehkan meninggalkan lokasi PIHAK PERTAMA dan meminta Peserta yang bersangkutan untuk menandatangani seluruh lembar pengesahan *LoC (Letter of Confirmation)* dan rincian tagihan dimaksud untuk dilampirkan pada saat penagihan kepada PIHAK KEDUA;
- v. Apabila dari hasil pemeriksaan dokter gigi umum sebagai fasilitas Rawat Jalan tingkat pertama Peserta disarankan untuk mendapatkan layanan dokter gigi spesialis, maka dokter gigi umum akan memberikan Surat Rujukan ke pelayanan Rawat Jalan tingkat lanjutan pada dokter gigi spesialis;
- vi. Dalam pemberian Pelayanan Medik Gigi Dasar, PIHAK PERTAMA diharuskan untuk tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada Peserta.

d. Rawat Gigi Tingkat Lanjutan (RGTL)

- i. Bagi Peserta yang dirujuk untuk mendapatkan Pelayanan Medik Gigi Spesialistik pada dokter gigi spesialis, maka peserta diwajibkan untuk membawa dan menunjukkan Kartu Identitas asli/Kartu Keluarga/Kartu Identitas Anak/Paspor, dan Kartu Peserta atau *e-card*, dan Surat Rujukan dari dokter gigi umum yang memberikan Pelayanan Medik Gigi Dasar kepada Poli Gigi Spesialis di Lokasi PIHAK PERTAMA saat melakukan pendaftaran;

- ii. Poli Gigi Spesialis PIHAK PERTAMA harus memastikan eligibilitas Peserta yang akan melakukan pemeliharaan kesehatan melalui akses Kartu Peserta atau *e-card* pada *Front End System* TPA untuk mencetak *LoA (Letter of Authorization)*. Setelah mendapatkan *LoA (Letter of Authorization)*, maka Peserta berhak untuk mendapatkan Pelayanan Medik Gigi Spesialistik pada Poli Spesialis PIHAK PERTAMA;
- iii. PIHAK PERTAMA wajib mencetak *LoC (Letter of Confirmation)* dan menuliskan diagnosa, serta rincian tagihan pelayanan kesehatan sebelum Peserta diperbolehkan meninggalkan Lokasi PIHAK PERTAMA dan meminta Peserta yang bersangkutan untuk menandatangani seluruh lembar pengesahan *LoC (Letter of Confirmation)* dan rincian tagihan dimaksud untuk dilampirkan pada saat penagihan kepada PIHAK KEDUA;
- iv. Apabila dari hasil pemeriksaan dokter Poli Gigi Spesialis sebagai fasilitas Rawat Jalan tingkat lanjutan Peserta disarankan untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan pada dokter gigi spesialis lainnya, maka dokter gigi spesialis dapat memberikan rujukan kepada dokter gigi spesialis lainnya dengan masa berlaku selama 7 (tujuh) Hari Kalender;
- v. Bagi Peserta yang menjalani proses Pelayanan Gigi Medik Spesialistik dengan Surat Rujukan dari Dokter PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud butir iv ayat ini, maka untuk Pelayanan Medik Gigi Spesialistik selanjutnya dengan diagnosa yang sama, Surat Rujukan tersebut dapat digantikan dengan Surat Kontrol yang memiliki masa berlaku selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
- vi. Dalam pemberian Pelayanan Gigi Medik Spesialistik, PIHAK PERTAMA diharuskan untuk tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada Peserta.

(2) PELAYANAN PESERTA ASURANSI KESEHATAN INDEMNITY PLUS

a. Rawat Jalan

- i. Untuk mendapatkan pelayanan Rawat Jalan pada PIHAK PERTAMA, Peserta harus membawa dan menunjukkan kartu identitas asli/kartu keluarga/kartu identitas anak/paspor dan Kartu Peserta atau *e-card* saat melakukan pendaftaran;
- ii. Pendaftaran PIHAK PERTAMA wajib memastikan eligibilitas Peserta yang melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan Kartu Peserta atau *e-card* yang ditunjukkan oleh Peserta. Apabila Peserta dengan alasan apapun tidak dapat menunjukan Kartu Peserta atau *e-card* maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai Pasien Umum yang bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- iii. PIHAK KEDUA melalui Petugas Pendaftaran PIHAK PERTAMA berhak melakukan Verifikasi lainnya (selain Kartu Peserta atau *e-card*) untuk menentukan keabsahan identitas Peserta sebagaimana dipersyaratkan dalam Polis Peserta dan/atau Kebijakan Fasilitas Kesehatan Perusahaan Peserta. Jika ditemukan perbedaan data pada proses Verifikasi lanjutan yang dilakukan maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai Pasien Umum yang bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- iv. Setelah memastikan eligibilitas Peserta, pelayanan Kesehatan dapat dilakukan melalui proses pendaftaran pada *Front End System* PIHAK KEDUA untuk mencetak *LoA (Letter of Authorization)*;
- v. Jika *LoA (Letter of Authorization)* berisi persetujuan, selanjutnya Peserta akan menerima Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di PIHAK PERTAMA;

- vi. Jika *LoA (Letter of Authorization)* berisikan penolakan, maka Peserta akan menerima Pelayanan Kesehatan sebagai Pasien Umum yang berlaku di PIHAK PERTAMA. Kecuali ditentukan lain sesuai informasi yang tercantum dalam *LoA (Letter of Authorization)*;
- vii. Apabila pemeriksaan kesehatan Rawat Jalan selesai, Peserta berkewajiban untuk memberikan *LoA (Letter of Authorization)* kepada petugas kasir PIHAK PERTAMA;
- viii. Setelahnya petugas kasir PIHAK PERTAMA wajib mencetak *LoC (Letter of Confirmation)* dan menuliskan diagnosa, jumlah biaya perawatan, serta rincian tagihan Pelayanan Kesehatan sebelum Peserta diperbolehkan meninggalkan Lokasi PIHAK PERTAMA dan meminta Peserta yang bersangkutan untuk menandatangani seluruh lembar pengesahan *LoC (Letter of Confirmation)* pada tanggal yang sama dimana Peserta mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan rincian tagihan dimaksud untuk dilampirkan pada saat penagihan kepada PIHAK KEDUA;
- ix. Pengesahan *Letter of Confirmation (LoC)* yang tidak sesuai dengan tanggal dimana Peserta mendapatkan Pelayanan Kesehatan tidak dapat ditagihkan kepada PIHAK KEDUA;
- x. Dalam hal timbul biaya maka PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan kepada Peserta dan/atau keluarga Peserta sebelum dilakukannya pemeriksaan kesehatan dan/atau tindakan. Jika terdapat eksekusi, maka eksekusi tersebut akan ditagihkan langsung kepada Peserta kecuali ditentukan lain dalam *LoA (Letter of Authorization)* dan *LoC (Letter of Confirmation)* dimaksud;
- xi. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan penutupan transaksi maksimum 1x24 jam, jika lewat dari batas waktu tersebut *Front End System* akan tertolak secara otomatis;
- xii. Dalam pemberian Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, PIHAK PERTAMA diharuskan untuk tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada Peserta.

b. Pelayanan Rawat Gigi

- i. Pelayanan Medik Gigi di Poli Gigi PIHAK KEDUA dapat menerima Peserta dengan jadwal sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
- ii. Untuk mendapatkan Pelayanan Medik Gigi pada Poli Gigi PIHAK KEDUA, Peserta harus membawa dan menunjukkan Kartu Identitas asli/Kartu Keluarga/Kartu Identitas Anak/Paspor, dan Kartu Peserta atau *e-card* kepada Poli Gigi PIHAK KEDUA saat melakukan pendaftaran;
- iii. PIHAK KEDUA harus memastikan eligibilitas Peserta yang akan melakukan pemeliharaan kesehatan melalui akses Kartu Peserta atau *e-card* pada *Front End System* untuk mencetak *LoA (Letter of Authorization)*. Setelah mendapatkan *LoA (Letter of Authorization)*, maka Peserta berhak untuk mendapatkan Pelayanan Medik Gigi dari Poli Gigi PIHAK KEDUA;
- iv. Apabila pemeriksaan kesehatan pada Pelayanan Medik Gigi selesai, PIHAK KEDUA wajib mencetak *LoC (Letter of Confirmation)* dan menuliskan diagnosa, serta rincian tagihan pelayanan kesehatan sebelum Peserta diperbolehkan meninggalkan lokasi PIHAK KEDUA dan meminta Peserta yang bersangkutan untuk menandatangani seluruh lembar pengesahan *LoC (Letter of Confirmation)* dan rincian tagihan dimaksud untuk dilampirkan pada saat penagihan kepada PIHAK PERTAMA;
- v. Dalam pemberian Pelayanan Gigi Medik Spesialistik, PIHAK KEDUA diharuskan untuk tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada Peserta.

B. PELAYANAN RAWAT INAP

(1) Pendaftaran Peserta Rawat Inap (*Admission*)

- a. Untuk mendapatkan pelayanan Rawat Inap, Peserta harus membawa dan menunjukkan Kartu Identitas asli/Kartu Keluarga/Kartu Identitas Anak/Paspor, dan Kartu Peserta atau *e-card* yang masih berlaku kepada Petugas Pendaftaran PIHAK KEDUA;
- b. Apabila Peserta dengan alasan apapun tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta atau *e-card* dan adanya perbedaan data yang ditampilkan pada alat konfirmasi, maka Peserta tersebut akan diperlakukan sebagai Pasien Umum yang bukan merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- c. Petugas Pendaftaran PIHAK KEDUA wajib memastikan eligibilitas Peserta yang berobat atau akan dirawat sesuai dengan Kartu Peserta atau *e-card*, yang selanjutnya akan memeriksa Kartu Peserta atau *e-card* serta hak Peserta dengan melakukan Validasi melalui *Front End System*, dan juga berkewajiban untuk memasukkan Kode Diagnosa penyakit Peserta;
- d. *Front End System* akan mencetak *LoA (Letter of Authorization)*, yang dapat berisi penolakan atau persetujuan;
- e. Jika *LoA (Letter of Authorization)* berisi persetujuan, maka Petugas Pendaftaran PIHAK KEDUA melakukan pembuatan Surat Persetujuan Layanan (Form Permintaan Jaminan) lalu melakukan unggah dokumen di Form Permintaan Jaminan yang telah di buat melalui *Front End System*, selanjutnya Petugas Pendaftaran PIHAK KEDUA akan menghubungi PIHAK PERTAMA untuk melakukan tindak lanjut atas Pendaftaran Rawat Inap dimaksud dalam waktu maksimum 60 (enam puluh) menit setelah terjadi Penggesekan atau Validasi Rawat Inap di *Front End System*, kecuali jika ada hal-hal yang di luar kendali PIHAK PERTAMA namun tidak terbatas pada gangguan jaringan telepon atau PIHAK KEDUA sulit dihubungi;
- f. PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 1x24 jam akan mengkonfirmasi kembali kepada PIHAK KEDUA jika Peserta yang bersangkutan berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan mengirimkan Surat Jaminan Rawat Inap, atau Peserta tidak berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan mengirimkan Surat Penolakan Rawat Inap dengan ketentuan bahwa informasi medis, dokumen–dokumen rawat inap dan data penunjang lainnya terhadap Peserta bersangkutan harus sudah diterima oleh PIHAK KEDUA maksimum 7 (tujuh) jam setelah Peserta melakukan pendaftaran Rawat Inap;
- g. Dalam hal PIHAK PERTAMA mengirimkan Surat Penolakan Rawat Inap, maka seluruh biaya atas Pelayanan Kesehatan yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta;
- h. Peserta berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Formulir Administrasi Rawat Inap yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK PERTAMA;
- i. Dalam hal Validasi melalui *Front End System* tidak bisa dilakukan (*offline*), jika dalam waktu 1x24 jam PIHAK KEDUA tidak melakukan pembuatan Surat Jaminan dan mengkonfirmasi kepada PIHAK PERTAMA, maka Pendaftaran Rawat Inap yang telah dilakukan pada *Front End System* akan tertolak secara otomatis.

(3) Proses Peserta Pulang Rawat Inap (*Discharge*)

- a. Berdasar keterangan atau informasi oleh Dokter PIHAK KEDUA yang merawat bahwa peserta diizinkan pulang atau selesai menjalani Rawat Inap, maka PIHAK KEDUA agar segera menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA dan Peserta tanpa harus menunggu sampai dengan batas waktu tertentu dengan maksud menambah jumlah hari perawatan;
- b. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan proses tagihan akhir Peserta Rawat Inap dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam setelah Peserta diizinkan pulang oleh Dokter yang merawat. Apabila melebihi batas waktu tersebut, maka Peserta PIHAK PERTAMA dapat dipulangkan tanpa jaminan. PIHAK KEDUA dapat meminta Peserta untuk menandatangani surat pernyataan kesiapan pembayaran. Dalam hal terdapat biaya ekses, maka penyelesaian pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Peserta kepada PIHAK KEDUA;

- c. PIHAK KEDUA wajib memastikan bahwa Peserta atau Keluarga Peserta menandatangani seluruh tagihan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta, yang berkaitan dengan tagihan perawatan yang bersangkutan;
- d. Bagi Peserta yang diberikan Surat Kontrol Pasca Rawat Inap oleh Dokter PIHAK KEDUA maka Surat Kontrol tersebut dapat digunakan sebagai pengganti Surat Rujukan yang berlaku untuk 1 (satu) kali;
- e. Petugas PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA pada H-1 sebelum Peserta diperbolehkan keluar/pulang dari lokasi PIHAK KEDUA dengan mengirimkan Tagihan Akhir dan Ringkasan Medis ke PIHAK PERTAMA melalui faksimile atau surat elektronik (*email*);
- f. Setelah menerima Tagihan Akhir dan Ringkasan Medis dimaksud, PIHAK PERTAMA melakukan Validasi Kelayakan atas tagihan dan ringkasan medis tersebut;
- g. Dalam hal timbul ekses atau selisih biaya maka PIHAK KEDUA wajib menginformasikan sebelumnya kepada Peserta dan atau keluarga Peserta, dan ekses tersebut menjadi tanggungan Peserta yang bersangkutan serta wajib ditagihkan langsung dan diselesaikan Peserta sebelum meninggalkan lokasi PIHAK KEDUA.

(4) Ketentuan Pelayanan Rawat Inap

- a. Dalam hal Peserta harus menjalani Rawat Inap di PIHAK KEDUA, maka hak Peserta atas kelas/kamar perawatan ditentukan sebagai berikut:
 - i. Hak Peserta atas kelas/kamar perawatan adalah sesuai dengan kelas/kamar perawatan yang menjadi haknya sebagaimana tercantum pada Kartu Peserta yang bersangkutan.
 - ii. Dalam hal Peserta atas kehendak sendiri dengan alasan apapun mengambil kelas/kamar perawatan di atas kelas/kamar perawatan yang menjadi haknya, maka selisih biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut BUKAN merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, tetapi akan menjadi tanggung jawab dan beban Peserta.
 - iii. Dalam hal Peserta atas kehendak sendiri dengan alasan apapun mengambil kelas/kamar perawatan di bawah kelas/kamar perawatan yang menjadi haknya, maka selisih biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut tidak dapat diuangkan dan tidak dapat diklaim ke PIHAK PERTAMA, baik oleh Peserta maupun PIHAK KEDUA.
- b. Pengaturan Hak Kelas/Kamar Rawat Inap Peserta sesuai data yang tercantum dalam *LoA (Letter of Authorization)* yang ditetapkan PIHAK PERTAMA, dan Peserta yang memerlukan Rawat Inap akan ditempatkan pada kelas perawatan yang menjadi haknya.
- c. Toleransi kenaikan kelas/kamar perawatan dapat diberikan jika kelas/kamar perawatan di PIHAK KEDUA yang sesuai dengan Plan Peserta PENUH dan TIDAK TERSEDIA (dibuktikan secara tertulis dari PIHAK KEDUA):
 - i. Jika kelas/kamar perawatan TIDAK TERSEDIA, maka Peserta diberikan toleransi di kelas/kamar perawatan lebih tinggi dari pada hak kelas kamarnya dan dijamin dalam jangka waktu 2x24 jam dari tanggal masuk. Atas toleransi tersebut, Peserta tidak dibebankan selisih biaya perawatan dan penggantian akan diberikan sebesar daftar manfaat sesuai tagihan.
 - ii. Jika kelas yang lebih tinggi (satu kelas di atasnya) juga tidak tersedia, maka PIHAK PERTAMA menawarkan untuk memindahkan Peserta ke Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas sesuai hak Peserta.
 - iii. Apabila pada hari ke-3 dan seterusnya kelas/kamar perawatan yang menjadi hak Peserta masih belum tersedia dan Peserta tetap menghendaki untuk dirawat pada kelas/kamar perawatan lebih tinggi daripada yang menjadi haknya, maka Peserta diberikan opsi untuk tetap menempati kelas/kamar perawatan yang lebih tinggi tersebut dengan selisih biaya ditanggung oleh Peserta (menjadi ekses) dan Peserta

berkewajiban untuk membuat Surat Pernyataan Pindah Kelas, atau Peserta diberi opsi turun kelas/kamar Rawat Inap.

- iv. Namun Apabila kelas/kamar perawatan yang menjadi hak Peserta tersedia (melewati batas waktu toleransi), maka PIHAK PERTAMA dapat mempertimbangkan untuk memindahkan Peserta.
- v. Toleransi kenaikan kelas/kamar perawatan tidak berlaku jika kenaikan kelas/kamar Perawatan dilakukan atas permintaan sendiri atau Peserta tidak tersedia untuk turun kelas, maka Peserta menanggung seluruh selisih biaya yang diakibatkan oleh kenaikan kelas/kamar perawatan yang ditempati dengan kelas/kamar perawatan haknya terhitung sejak hari tersedianya kelas/kamar perawatan yang menjadi haknya.
- vi. Seluruh tanggungan sendiri yang menjadi beban Peserta saat di rawat inap akan ditagihkan langsung oleh PIHAK KEDUA kepada Peserta, kecuali ada persetujuan jaminan tertulis dari Perusahaan Peserta.
- d. Dalam hal Peserta mengambil kelas/kamar perawatan di atas haknya, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada Peserta mengenai konsekuensi yang timbul dari hal tersebut dan meminta kepada Peserta untuk terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan sanggup membayar selisih biaya yang timbul.
- e. Rawat Inap dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan per Peserta secara akumulatif dalam 1 (satu) tahun, kecuali atas rekomendasi *Medical Advisory Board (MAB)*.
- f. Dalam hal Peserta memerlukan perawatan di ruang khusus (*Intensive Care Unit (ICU)/Intermediate/isolasi*) maka PIHAK KEDUA harus dapat menyampaikan keterangan tertulis perihal indikasi terkait kebutuhan menempati ruangan khusus tersebut serta berkoordinasi PIHAK PERTAMA mengenai tarif tindakan dan jasa dokter sesuai dengan hak kelas Peserta.
- g. Bagi PIHAK KEDUA yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka PIHAK PERTAMA dengan persetujuan PIHAK KEDUA dapat memberlakukan COB (*Coordination of Benefit*) berupa Urun Biaya (*Cost Sharing*) bagi Peserta PIHAK PERTAMA yang merupakan Pasien dengan *emergency* yang dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Dalam hal tersebut, maka PIHAK KEDUA wajib untuk:
 - i. Menagihkan klaim dalam Sistem Tarif INA CBG's kepada BPJS Kesehatan, sedangkan selisihnya ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA melalui sistem COB (*Coordination of Benefits*);
 - ii. Memastikan Sistem COB (*Coordination of Benefits*) yang diterapkan memenuhi ketentuan/ regulasi dan *Standar Operating Procedure (SOP)* yang berlaku pada BPJS Kesehatan; dan
 - iii. Memastikan Standar Layanan yang diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan layanan yang disepakati (tidak ada penurunan standar) dalam penerapan sistem COB (*Coordination of Benefits*).
- h. Pada saat Peserta menerima Pelayanan Kesehatan Rawat Inap, PIHAK PERTAMA memiliki Otorisasi untuk melakukan Pemantauan terhadap Peserta dimaksud (*monitoring*) secara harian (*daily*).

C. PELAYANAN INSTALANSI GAWAT DARURAT

- (1) Untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Kondisi Gawat Darurat, Peserta harus membawa dan menunjukkan Kartu Identitas asli/Kartu Keluarga/Kartu Identitas Anak/Paspor dan Kartu Peserta atau *e-card*.
- (2) Apabila Peserta tidak membawa atau menunjukkan Kartu Peserta atau *e-card* sebagaimana ayat 1 Lampiran ini dan kondisi Peserta membutuhkan pertolongan pertama, maka Peserta diprioritaskan masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) terlebih dahulu. Informasi kepesertaan selanjutnya tetap harus disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah keluarga Peserta melapor kepada PIHAK PERTAMA.

- (3) Pelayanan Kondisi Gawat Darurat dapat dilayani oleh PIHAK KEDUA apabila Peserta memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Sakit yang diderita Peserta memenuhi kriteria Kondisi Gawat Darurat
 - b. Peserta berobat pada hari Libur atau hari Libur Nasional
 - c. Peserta berobat pada hari Senin hingga hari Sabtu di luar jam operasional Poli Rawat Jalan.
- (4) Dalam Kondisi Gawat Darurat, PIHAK KEDUA dapat memberikan Tindakan Operasi atau Tindakan Medis lainnya tanpa persetujuan Peserta dan atau Keluarga Peserta dalam hal tidak ada yang mendampingi Peserta, selanjutnya PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA.
- (5) Dalam hal situasi Peserta dalam keadaan kritis, tindakan medis apa pun yang diputuskan harus memperhatikan *outcome* jangka pendek dan jangka panjang, dan tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada Peserta apabila tidak disertai rekomendasi bukti ilmiah.
- (6) Untuk peserta Asuransi Kesehatan Managed Care Plus, layanan IGD sebagai FKTP dengan ketentuan berikut:
 - a. Hari Senin s/d Jumat, mulai pukul 16:00 s/d 08:00 (waktu Indonesia di wilayah masing-masing)
 - b. Hari Sabtu, mulai pukul 12:00 (waktu Indonesia di wilayah masing-masing)
 - c. Hari Minggu, 24 jam (waktu Indonesia di wilayah masing-masing)
 - d. Keadaan Kegawatdaruratan dapat langsung dilayani di IGD
- (7) Pengobatan Kondisi Gawat Darurat dilakukan di fasilitas kesehatan bukan Penyedia Layanan Kesehatan PIHAK PERTAMA, akan diberikan melalui mekanisme Restitusi atau *Reimbursement*.

D. PELAYANAN PENYEDIAAN OBAT

- (1) PIHAK KEDUA hanya akan melayani dan menerima Peserta yang membawa dan menunjukkan Kartu Identitas asli/Kartu Keluarga/Kartu Identitas Anak/Paspor, dan Kartu Peserta atau *e-card*, *LoC* (*Letter of Confirmation*), dan Resep dari Dokter Penyedia Layanan Kesehatan PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan obat, sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA dengan prioritas pemberian sesuai urutan sebagai berikut:
 - a. Obat Generik.
 - b. Obat Produksi Perusahaan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).
 - c. Obat Produksi Perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing).
 - d. Obat Original (Paten).
- (3) Jenis Obat yang diberikan oleh PIHAK KEDUA diutamakan adalah Obat Generik, DOEN atau Obat yang setara dengan Standar Obat PIHAK PERTAMA.
- (4) Obat-obatan yang diberikan kepada Peserta sesuai Formularium Obat (FO) dan Daftar Obat Perseroan (DOP) dari PIHAK PERTAMA. Kecuali jika tidak ada dalam Formularium Obat (FO) dan Daftar Obat Perseroan (DOP) dari PIHAK PERTAMA, maka dapat diberikan obat-obatan sejenis berdasarkan Daftar Obat Kesepakatan (DOK) antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, atau berdasarkan pertimbangan medis dengan mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- (5) Dalam memberikan Pelayanan Kesehatan pada Peserta khususnya penulisan Resep, PIHAK KEDUA wajib menyertakan edukasi perihal kuantitas dan fungsi obat sesuai indikasi medis, serta prioritas jenis obat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam melakukan pemberian Resep untuk Peserta, PIHAK KEDUA wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk jenis penyakit akut, penulisan Resep maksimal 4 (empat) produk obat untuk maksimal 5 (lima) Hari Kalender.
 - b. Untuk 1 (satu) jenis penyakit kronis, penulisan Resep maksimal 3 (tiga) produk obat untuk maksimal 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
 - c. Dalam 1 (satu) produk obat yang bersifat racikan dapat terdiri dari beberapa formula obat yang dihitung sebagai 1 (satu) produk obat.

- (7) Vitamin yang dijamin oleh PIHAK PERTAMA melalui persetujuan kepada PIHAK KEDUA dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Peserta Rawat Inap yang membutuhkan vitamin sesuai rekomendasi Dokter yang merawat.
 - b. Peserta pasca Rawat Inap atau dalam masa penyembuhan atas rekomendasi Dokter yang merawat.
 - c. Peserta yang menderita Hepatitis Kronis, TBC, Karsinoma (Kanker), Autoimun, Lupus, dan Cachexia.
 - d. Peserta yang menderita Defisiensi Vitamin.
 - e. Peserta dengan Gangguan Saraf yang telah dibuktikan dengan Pemeriksaan Penunjang Neurologis.
 - f. Peserta adalah Ibu Hamil dan Anak sampai dengan usia 12 (dua belas) tahun.
 - g. Vitamin untuk Rawat Jalan, di luar kondisi yang disebutkan, dapat dijamin dengan ketentuan:
 - i. Untuk penyakit akut;
 - ii. Tidak berdiri sendiri dalam resep/ada obat utama;
 - iii. Dijamin untuk maksimal sebanyak 10 butir per resep;
 - iv. Merupakan produksi dalam negeri;
 - v. Sesuai klasifikasi *Monthly Index of Medical Specialities (MIMS)*.
 - h. Dalam hal biaya pada Resep untuk 1 (satu) jenis obat di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan/atau biaya total pada 1 (satu) Resep obat di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka PIHAK KEDUA wajib meminta persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, kecuali untuk tindakan darurat yang membutuhkan pertolongan sangat segera dapat dilakukan, yang selanjutnya disampaikan pemberitahuan tindakan secara tertulis dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam.
 - i. Pada saat penyerahan obat bagi Peserta, PIHAK KEDUA harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Dilakukan pemotongan kemasan obat (tidak diberikan dalam keadaan strip utuh).
 - ii. Pemotongan kemasan obat dilakukan di depan Peserta sesaat sebelum penyerahan obat dengan terlebih dahulu menginformasikan waktu kadaluarsa dari obat tersebut.
 - iii. Penyerahan obat tidak menyertakan dus/box obat, kecuali lembaran informasi obat tetap diberikan.
 - iv. Sediaan obat sirup kering telah dilarutkan di bagian farmasi.
 - v. Apabila terdapat keberatan/komplain dari Peserta, maka pemotongan kemasan obat tetap dilaksanakan, dan agar diinformasikan terkait Peserta yang keberatan/komplain tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
 - vi. Penyerahan obat dibuktikan dengan tanda terima yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA dan ditandatangani oleh Peserta.
 - j. Untuk Peserta Asuransi Kesehatan Managed Care Plus, dalam hal Peserta dengan penyakit kronis yang stabil tanpa ada keluhan memerlukan obat rutin, PIHAK KEDUA wajib melakukan Pelayanan Rujuk Balik ke FKTP.
 - k. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menarik biaya apapun terhadap Peserta sepanjang Pelayanan Obat yang diberikan masih tercakup dalam ruang lingkup serta memenuhi prosedur penyediaan dan pelayanan obat dari masing-masing produk atau Pelayanan Kesehatan.
 - l. Dalam hal di lokasi/kedudukan Peserta tidak tersedia Apotek yang merupakan Penyedia Layanan Kesehatan PIHAK PERTAMA, maka resep obat dapat dibeli langsung ke Apotek lainnya dengan mekanisme Restitusi atau *Reimbursement*.

E. PELAYANAN PENUNJANG

- (1) Pemeriksaan Penunjang antara lain pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan patologi anatomi, pemeriksaan diagnostik invasif, pemeriksaan elektromedis, dan kegiatan rehabilitatif yang termasuk antara lain kegiatan fisioterapi dan terapi wicara/okupasi.
- (2) Bagi Peserta Asuransi Kesehatan *Managed Care Plus*, untuk mendapatkan Pelayanan Pemeriksaan Penunjang, Peserta harus membawa dan menunjukkan Kartu Identitas asli/Kartu Keluarga/Kartu Identitas Anak/Paspor dan Kartu Peserta atau *e-card* kepada PIHAK KEDUA disertai:
 - a. Untuk pemeriksaan awal, dilampiri Surat Rujukan dari Dokter atau Klinik yang merupakan Penyedia Layanan Kesehatan PIHAK PERTAMA.
 - b. Untuk pemeriksaan lanjutan disertai Surat Rujukan dari Dokter Spesialis PIHAK KEDUA.
 - c. Untuk pemeriksaan Kegiatan Rehabilitatif meliputi kegiatan fisioterapi dan terapi wicara atau okupasi dilakukan maksimal 3 *Cure* (18 kali) dengan membawa Kartu Identitas asli/Kartu Keluarga/Kartu Identitas Anak/Paspor, dan Kartu Peserta atau *e-card*, serta jadwal fisioterapi, dan terapi wicara/okupasi.
- (3) Apabila dilakukan Pemeriksaan Penunjang, maka pemilihan jenis Pemeriksaan Penunjang harus ditulis dengan jumlah pilihan yang dituangkan dalam angka dan huruf pada Formulir Pemeriksaan Penunjang.
- (4) Apabila Pelayanan Penunjang dilakukan di selain yang merupakan Penyedia Layanan Kesehatan PIHAK PERTAMA, maka diberlakukan Restitusi atau *Reimbursement*.
- (5) Dalam Pemberian Pelayanan Penunjang, PIHAK KEDUA diharuskan untuk tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada Peserta.

F. KETENTUAN LAIN

- (1) PIHAK KEDUA wajib memberikan tindakan dengan berdasarkan pertimbangan Kesehatan/kondisi Peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal diperlukan terapi yang memerlukan biaya tinggi (antara lain suntikan interferon, sitostatika, dll) harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Dokter yang merawat dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
 - b. Pemeriksaan kesehatan dan atau tindakan yang tidak ditanggung/dijamin oleh PIHAK PERTAMA tetap wajib diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Peserta berdasarkan pertimbangan kesehatan/kondisi Peserta.
 - c. Menunjuk huruf b ayat ini tersebut di atas, dalam hal timbul ekses biaya maka PIHAK KEDUA wajib menginformasikan kepada Peserta dan atau keluarga Peserta sebelum dilakukannya pemeriksaan kesehatan dan atau tindakan.
- (2) PIHAK KEDUA dalam memberikan tindakan operasi/tindakan medis lainnya harus mendapat persetujuan Peserta/keluarga Peserta dan PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA dan wajib mentaati segala ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA, yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta.
 - a. Biaya mobilisasi/pemindahan yang timbul akibat dari Rujukan, dilaksanakan sesuai kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan lebih lanjut sebagaimana ketentuan pada PERJANJIAN ini.

LAMPIRAN III

PENGECUALIAN

- (1) Semua klaim atas biaya pemeriksaan, perawatan dan pengobatan yang dimulai sebelum Tanggal Efektif Polis, dan atau yang tidak tercantum dalam tabel manfaat dan atau tidak tercantum dalam polis maupun endorsement polis.
- (2) Ketentuan pengecualian untuk *Managed Care Plus* dan *Indemnity*, sebagai berikut:
 - a. Pada layanan *Managed Care Plus*, untuk konsultasi ke Dokter Ahli atau Dokter Spesialis harus dengan rujukan Dokter Umum kecuali sesuai dengan ketentuan polis masing-masing badan usaha.
 - b. Untuk layanan *Indemnity*, mengacu pada *benefit* yang dimiliki oleh Peserta.
- (3) Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan oleh keluarga dekat Peserta atau oleh seseorang yang secara normal tinggal serumah dengan Peserta.
- (4) Biaya non medis seperti telepon, laundry, thermometer, tensimeter, tidak terbatas pada penggunaan APD (baju hazmat, kacamata *goggle*, sarung tangan dan masker) dan sejenisnya.
- (5) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik untuk tujuan Skrining seperti Pap Smear, Uji Alergi, TORCH, uji Hepatitis, dan Mammografi; namun tidak terbatas seperti pada Pap Smear, Uji Alergi, TORCH, Uji Hepatitis, Mammografi yang tanpa indikasi medis spesifik.
- (6) Pemeriksaan, Perawatan, Penunjang Diagnostik dan obat-obatan yang tidak sesuai dengan diagnosa dan atau tanpa resep Dokter, maupun salinan resep atau iter.
- (7) Produk Herbal, kecuali obat herbal terstandar atau fitofarmaka yang berkaitan dengan Liver, Cardiovascular; dan dapat diberikan sesuai dengan Indikasi Medis dan Resep Dokter.
- (8) Obat Gosok, kecuali obat gosok yang mengandung zat aktif Natrium Diklofenak, Glukosamin, Piroxicam, Ketoprofen; dan diberikan maksimum 1 (satu) tube per bulan.
- (9) Produk MLM, Susu, Multivitamin, Mineral, Food Supplement dan sejenisnya yang termasuk dalam daftar yang dikeluarkan BPOM baik dengan rekomendasi Dokter maupun tanpa rekomendasi Dokter (yang dijamin adalah vitamin tunggal atau racikan obat atau puyer yang sesuai dengan diagnosa dan atas rekomendasi Dokter); atau jika berdiri sendiri sesuai ayat (2) Lampiran ini.
- (10) Layanan/prosedur medis atau bedah yang bersifat percobaan atau belum diakui sebagai pengobatan medis standar oleh organisasi profesi medis misalnya *Iridology*, *Cell implant Therapy*, *Laser Therapy* untuk koreksi refraksi, berbagai bentuk penyinaran lain atau obat yang belum disetujui oleh Departement Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (POM) termasuk di dalamnya pengobatan tradisional, pengobatan alternatif, perawatan hiperbarik dan akupunktur.
- (11) Perawatan dan pengobatan yang bersifat kosmetis / kecantikan / estetika termasuk bedah plastik kecuali bedah plastik rekonstruksi akibat kecelakaan yang dilakukan 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah kecelakaan, kosmetis gigi (termasuk perawatan orthodonti, pemutihan gigi dan seluruh rangkaiannya; atau jika berdiri sendiri sesuai ayat (2) Lampiran ini.
- (12) Perawatan dan atau pengobatan yang berkaitan dengan kelainan bawaan, penyakit keturunan (herediter), kelainan gizi, termasuk penarikan dan penurunan berat badan dan gangguan tumbuh kembang, sunat dan hernia di bawah usia 12 (dua belas) tahun; atau jika berdiri sendiri sesuai ayat (2) Lampiran ini.
- (13) Imunisasi untuk anak di atas usia 1 (satu) tahun, Imunisasi selain imunisasi dasar, Imunisasi lanjutan dan imunisasi untuk orang dewasa; atau jika berdiri sendiri sesuai ayat (2) Lampiran ini.
- (14) Sterilisasi bagi pria dan wanita (seperti tubektomi dan vasectomy), Komplikasi akibat KB, usaha inseminasi buatan, bayi tabung dan juga perawatan dan pemeriksaan yang berkaitan dengan kesuburan (usaha untuk memperoleh anak/fertilitas); atau jika berdiri sendiri sesuai ayat (2) Lampiran ini.
- (15) Semua penyakit yang berhubungan dengan hormonal imbalance lainnya (termasuk kista ovarium, myoma uteri, kista endometriosis, kelainan atau gangguan menstruasi, pra dan menopause, serta komplikasinya); atau jika berdiri sendiri sesuai ayat (2) Lampiran ini.

- (16) Semua perawatan dan atau pengobatan dengan alat bantu buatan, antara lain alat pacu jantung, kursi roda dan atau alat penyangga, stent (ring jantung), implant dan alat bantu lainnya, tranplantasi organ; atau jika berdiri sendiri sesuai ayat (2) Lampiran ini.
- (17) Pemeriksaan, perawatan dan pengobatan atau tindakan terhadap penyakit keganasan kanker (karsinoma) ataupun terindikasi keganasan kecuali yang sudah diatur dalam manfaat khusus.
- (18) Perawatan dan atau pengobatan yang berkaitan dengan gangguan mental, kejiwaan dan psikologis, *drugs abuse* (NAPZA); atau jika berdiri sendiri sesuai ayat (2) Lampiran ini.
- (19) Kondisi – kondisi yang berhubungan dengan penyakit – penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks/golongan penyakit kelamin dan segala akibatnya termasuk di dalamnya AIDS/HIV dan ARC (*AIDS Related Complex*).
- (20) Semua perawatan dan atau pengobatan yang berhubungan dengan penyakit–penyakit/wabah dan atau pandemic yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pusat yang meliputi (namun tidak terbatas), yaitu SARS, MERS, Coronavirus (Covid-19) dan lain sebagainya.
- (21) Perawatan dan atau pengobatan yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung dari:
 - a. Pemogokan, kerusakan, huru-hara, perkelahian, perbuatan kriminal atau aktifitas yang berhubungan dengan teroris, sedang melaksanakan tugas militer.
 - b. Perang, bencana alam.
 - c. Radiasi Ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakar nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan – bahan senjata nuklir.
 - d. Luka yang disengaja, bunuh diri atau percobaan bunuh diri.
 - e. Keikutsertaan dalam aktifitas atau olahraga berbahaya seperti: mendaki gunung, panjat tebing, panjat gedung, bungee jumping, Arung Jeram, menyelam, Olahraga profesional (bayaran), lomba kecepatan.
 - f. Melakukan penerbangan dengan menggunakan pesawat carteran, militer/polisi atau helikopter (non komersial).
- (22) Jika diketahui saat diagnosa awal maka tidak dapat diberikan surat jaminan.
- (23) Jika diagnosa termasuk pengecualian Polis diketahui sejak awal maka seluruh biaya tidak dapat dijamin (Pasien Umum Rangkai).
- (24) Jika diketahui saat diagnosa akhir maka biaya yang timbul sebelum diagnosa akhir termasuk biaya yang dikecualikan.
- (25) Jika diagnosa akhir diketahui sebagai pengecualian polis dalam masa perawatan maka seluruh biaya Peserta sejak awal perawatan tidak dapat dijamin dan menjadi tanggungan Peserta (sebagai Pasien Umum).
- (26) Pengecualian lain yang terdapat pada pemberitahuan tersendiri merujuk ketentuan Polis pada masing-masing Badan Usaha.

LAMPIRAN IV

TARIF KESEPAKATAN DAN/ATAU HAK ISTIMEWA (*Privilege*)

1. Selama berlakunya Perjanjian, PIHAK PERTAMA memberikan Hak Istimewa (*Privilege*) kepada PIHAK KEDUA sesuai tabel berikut :

No.	KETERANGAN	KETENTUAN
1)	Buku Tarif	Tahun 2024
2)	Diskon: Tagihan (total tagihan, obat, layanan gigi, biaya konsul Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Subspesialis) Biaya Administrasi Rawat Inap Biaya Administrasi Rawat Jalan	Diskon Total Tagihan sebesar 3% Biaya Konsul Dokter Umum. Rp 190.000,- Biaya Konsul Dokter Spesialis Rp 250.000,- Biaya Konsul Dokter Subspesialis Rp ..., - Biaya Administrasi Rawat Inap 3% maks. Rp. 1.000.000,- Free Biaya Administrasi Rawat Jalan. PARA PIHAK akan melakukan rekonsiliasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna memastikan kesesuaian data PARA PIHAK terhadap diskon yang telah diberikan kepada PIHAK PERTAMA. Pelaksanaan rekonsialisasi tersebut mengacu tanggal dimulainya kerja sama PARA PIHAK berdasarkan AMANDEMEN ini.
3)	Hak Istimewa (<i>Privilege</i>) Naik Kelas Kamar Rawat Inap Apabila Kelas Rawat Inap Full Layanan Ambulans dan Kendaraan Antar Jemput Peserta menuju Lokasi Perawatan Pengantaran Obat	Upgrade 1 (satu) Tingkat, tanpa biaya selisih. Dapat dijamin selama 2 x 24 jam. Jika Peserta tetap menghendaki untuk dirawat pada kelas setingkat lebih tinggi daripada haknya, maka Peserta berkewajiban untuk membuat Surat Pernyataan Pindah Kelas dan seluruh selisih biaya menjadi tanggung jawab Peserta. Layanan Gratis Ambulans dan Kendaraan Antar Jemput bagi Peserta menuju Lokasi Perawatan (termasuk penggunaan, pengantaran dan driver) dalam radius.....kilometer. Pengantaran obat ke alamat Peserta dalam radius kilometer.

2. Ketentuan Hak Istimewa (*Privilege*) kepada PIHAK KEDUA tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal yang disebutkan dalam Pasal 9.

3. Perubahan hak istimewa (*Privilege*) dimaksud dalam tabel butir 1 di atas dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dan untuk perubahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PERJANJIAN ini.

LAMPIRAN V
TATA CARA PENAGIHAN & PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN

1. Tata Cara Penagihan Pelayanan Kesehatan Asuransi Kesehatan dan *ASO as Payor*
 - a. Tagihan atas biaya Pelayanan Kesehatan dikirim oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - i. Berkas tagihan *softcopy* di unggah *Front End System* dengan melampirkan dokumen, sebagai berikut:
 - a) Kwitansi asli (bermaterai), dan rekapitulasi tagihan klaim
 - b) Formulir Pelayanan Medis (Form Klaim) atau bukti kunjungan yang ditandatangani oleh Peserta
 - c) Fotokopi hasil pemeriksaan penunjang diagnostik bila dilakukan antara lain Dokter Praktek Mandiri, radiologi, dan pemeriksaan penunjang lainnya
 - d) Surat Rujukan
 - e) Fotokopi Resep
 - f) Resume Medis (khusus untuk rawat inap)
 - g) Fotokopi KTP (untuk yang tidak menggunakan aplikasi mobile)
 - h) Surat Jaminan (khusus untuk rawat inap atau tindakan khusus)
 - ii. Berkas tagihan *hardcopy* dikirim kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
 - a) Tagihan (*invoice*) besar
 - b) Rekapitulasi Tagihan (terdiri atas rangkuman rekapan Peserta)
 - c) Surat Jalan (SJL) atau *Transaction Verification Form* (TVF)
 - d) Faktur Pajak bagi Provider sebagai WAPU (Wajib Pungut) Pajak
 - b. Formulir Klaim yang diisi dengan lengkap dan benar, ditandatangani oleh Peserta dan Dokter yang merawat dan dibubuhi stempel Dokter dengan mencantumkan nomor Surat Izin Praktik (SIP) Dokter serta dibubuhi stempel dari PIHAK KEDUA.
 - c. Kwitansi Pengobatan ditandatangani Petugas Administrasi Pembayaran disertai dengan nama jelas atau ditandatangani oleh Dokter yang merawat serta dibubuhi stempel yang berisi nama jelas dan nomor SIP serta dibubuhi stempel dari PIHAK KEDUA.
 - d. Untuk berkas klaim Rawat Jalan dan Rawat Inap Umum sesuai pada Pasal 13 PERJANJIAN ini.
 - e. Bukti pelayanan lain yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (bila ada) contoh: Laporan Operasi, Protokol Terapi dan Regimen Pemberian Obat Khusus, Perincian Tagihan Klinik (*manual* atau *automatic billing*).
 - f. Dokumen dikirimkan ke PIHAK PERTAMA dilengkapi dengan Tanda Terima List Rekapitulasi Global atas dokumen-dokumen yang dikirimkan. Jika ditemukan ketidak sesuaian PIHAK PERTAMA akan kofirmasi ke PIHAK KEDUA terkait melalui media Email/Faksimile/Telepon.
 - g. Dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah berkas tagihan diterima, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana disebutkan dalam PERJANJIAN ini. Jika dokumen klaim yang dikirimkan tersebut tidak lengkap, maka tagihan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA tanpa konfirmasi.
 - h. Jika terdapat pembetulan (revisi) tagihan, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengubah kwitansi senilai perubahan tersebut.
 - i. PIHAK KEDUA wajib mengirimkan tagihan atas biaya Pelayanan Kesehatan dalam dokumen tagihan yang terpisah.
2. Tata Cara Pembayaran Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Asuransi Kesehatan dan *ASO as Payor*
 - a. Tagihan atas Biaya Pelayanan Kesehatan dikirimkan ke:

PT Asuransi Perisai Listrik Nasional

Jl. KH Guru Amin Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780 (d/h Jl. Raya Pasar Minggu No.5, Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780).

- b. Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tagihan lengkap diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Pembayaran akan dilakukan PIHAK PERTAMA dengan proses pemindahbukuan bank (bank transfer) ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

RS PRIMA HUSADA MALANG

- Bank : PT. BANK CENTRAL ASIA
- Cabang : KK MALANG - SINGOSARI
- No.Rekening : 368-3040700
- Atas Nama : PT. DISA PRIMA MEDIKA
- NPWP : 211370721657000/0211370721657000

RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

- Bank : PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk
- Cabang : KK MALANG - BLIMBING
- No.Rekening : 144-0055533324
- Atas Nama : PT. DISA PRIMA MEDIKA
- NPWP : 211370721624001/0211370721657000

3. Tata Cara Penagihan dan Pembayaran Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan bagi Peserta *ASO Non Payor* dilakukan oleh Perusahaan Peserta sesuai dengan ketentuan dalam kontrak Perusahaan Peserta dengan PIHAK KEDUA.

LAMPIRAN VI
ALAMAT KORESPONDENSI, KONFIRMASI PENJAMINAN,
DAN KONFIRMASI TAGIHAN

1. ALAMAT KORESPONDENSI

a. PIHAK PERTAMA

PT Asuransi Perisai Listrik Nasional

Alamat : Gedung PLN Insurance
Jl. KH Guru Amin No. 5, Jakarta Selatan, 12780
Telepon : (021) 50878100; 081119062123
Faksimile : (021) 7972477
Email : provider@plninsurance.co.id

b. PIHAK KEDUA

PT DISA PRIMA MEDIKA

Banjararum No 3B, Mondoroko, Singosari Malang

a. Rumah Sakit Prima Husada Malang

Alamat : Banjararum Selatan No. 7 Mondoroko, Kec Singosari Malang
Telepon : (0341) 458679
Faksimile : -
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
PIC : Mayputri Nabilla, A. Md. Kes (0811 3507 164)

b. Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

Alamat : Jl. Raya Surabaya – Malang No. KM 54, Lemahbang, Sukorejo, Pasuruan
Telepon : (0343) 6745000
Faksimile : -
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
PIC : Rizqi Gitari Fernanda, A. Md. Kep (0813 1557 4065)

Dalam hal Lingkup kerja sama sebagaimana diatas pada lampiran ini, PIHAK KEDUA yang termasuk dalam Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan bagi peserta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah RS Prima Husada Malang dan RS Prima Husada Sukorejo.

Apabila terjadi perubahan data baik PIHAK KEDUA maupun PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja melalui email, surat, atau pembatuan data dalam *Front End System* sebelum tanggal penggantian/perubahan data.

2. KONFIRMASI PENJAMINAN

a. **Holding PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)**

Telepon : 087700012123 / 08118575123 - *Call Only*
08119580123 – *Whatsapp Only*
Email : penjaminan@plninsurance.co.id

b. **Sub Holding dan Group PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)**

Telepon : 150123 - *Call Only*

08118491123 - *Whatsapp Only*
Email : apln@plninsurance.co.id

c. **Indemnity melalui TPA PT Administrasi Medika (AdMedika)**

Alamat : Telkom Gambir, Gedung C
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 12 Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 29813040
Email : tugu.kresna@admedika.co.id

3. KONFIRMASI TAGIHAN

a. **Holding PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)**

(1) Regional Jawa – Madura – Bali (JAMALI)

- (i) Wilayah Jakarta & Bekasi
 - Telepon : 081119061123
 - Email : penagihan.jakarta_bekasi@plninsurance.co.id
- (ii) Wilayah Depok & Tangerang
 - Telepon : 081119068123
 - Email : penagihan.depok_tangerang@plninsurance.co.id
- (iii) Wilayah Jawa Barat & Jawa Tengah
 - Telepon : 081119934123
 - Email : penagihan.jabar_jateng@plninsurance.co.id
- (iv) Wilayah Jawa Timur & Denpasar
 - Telepon : 081119066123
 - Email : penagihan.jatim_denpasar@plninsurance.co.id
- (v) Seluruh Regional JAMALI, email tembusan ke penagihan.jamali@plninsurance.co.id

(2) Regional Sumatera & Kalimantan (SUMKAL)

- (i) Wilayah Aceh, Medan & Lampung
 - Telepon : 081119932123
 - Email : penagihan.aceh_medan_lampung@plninsurance.co.id
- (ii) Wilayah Padang, Palembang & Bangka-Belitung
 - Telepon : 081119935123
 - Email : penagihan.padang_palembang_babel@plninsurance.co.id
- (iii) Wilayah Pekanbaru, Balikpapan, Banjarbaru & Pontianak
 - Telepon : 081119069123
 - Email : penagihan.pekanbaru_balikpapan_banjarbaru_pontianak@plninsurance.co.id
- (iv) Seluruh Regional SUMKAL, email tembusan ke: penagihan.sumkal@plninsurance.co.id

(3) Regional Sulawesi – Maluku – Papua – Nusa Tenggara (SULMAPANA)

- Telepon : 081119074123
- Email : penagihan.sulmapana@plninsurance.co.id

b. **Selain Holding PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)**

Telepon : 081119225123
Email : claim.health@plninsurance.co.id

c. **Indemnity melalui TPA PT Administrasi Medika (AdMedika)**

Alamat : Telkom Gambir, Gedung C
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 12 Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 29813040
Email : tugu.kresna@admedika.co.id

LAMPIRAN VII
DAFTAR KLIEN
PT ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL

NO	CORPORATE GROUP	SISTEM PELAYANAN
1	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) - DIREKSI	VVIP – ASO MANAGED CARE PLUS
2	PT PLN BATAM – DIREKSI	VVIP - ASO MANAGED CARE PLUS
3	PT PLN NUSA DAYA – DIREKSI KOMISARIS	VVIP – ASO MANAGED CARE PLUS
4	PT PLN ENJINIRING - DIREKSI KOMISARIS	VVIP - ASO MANAGED CARE PLUS
5	PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA – DIREKSI	VVIP - INDEMNITY
6	PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA – DIREKSI KOMISARIS	VVIP - ASO MANAGED CARE PLUS
7	PT PAGUNATAKA CAHAYA NUSANTARA – DIREKSI	VVIP - ASO MANAGED CARE PLUS
8	PT HALEYORA POWER– DIREKSI	VVIP MANAGED CARE PLUS
9	PT HALEYORA POWERINDO – DIREKSI	VVIP - INDEMNITY
10	PT ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL - DIREKSI	VVIP - INDEMNITY
11	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	MANAGED CARE PLUS
12	PT PLN INDONESIA POWER - TUGAS KARYA	MANAGED CARE PLUS
13	PT PLN NUSANTARA POWER - TUGAS KARYA	MANAGED CARE PLUS
14	PT PLN ENERGI PRIMER INDONESIA - TUGAS KARYA	MANAGED CARE PLUS
15	PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA – PEGAWAI	MANAGED CARE PLUS
16	PT PLN BATAM	MANAGED CARE PLUS
17	PT PLN NUSA DAYA – PEGAWAI	MANAGED CARE PLUS
18	PT PLN ENJINIRING	MANAGED CARE PLUS
19	PT PAGUNATAKA CAHAYA NUSANTARA – PEGAWAI	MANAGED CARE PLUS
20	PT HALEYORA POWER	MANAGED CARE PLUS
21	PT HALEYORA POWER - TUGAS KARYA	MANAGED CARE PLUS
22	PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA - PEGAWAI	INDEMNITY
23	PT ANDIKA ENERGINDO	INDEMNITY
24	PT SINERGI PROPERTI PRATAMA	INDEMNITY
25	PT DANA PENSIUN PLN	INDEMNITY
26	PT ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL	INDEMNITY
27	PT NESINAK INDUSTRIES – TETAP	INDEMNITY
28	PT NESINAK INDUSTRIES – KONTRAK	INDEMNITY
29	PT JGC INDONESIA	INDEMNITY
30	PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL CABANG CILEGON	INDEMNITY

**DAFTAR KLIEN
PT ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL**

NO	CORPORATE GROUP	SISTEM PELAYANAN
31	PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL CABANG JAKARTA	INDEMNITY
32	PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL QQ SANKYU LOGISTIK INDONESIA (SLI)	INDEMNITY
33	PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL	INDEMNITY
34	PT YAMAHA INDONESIA	INDEMNITY
35	PT SDS INTERNATIONAL	INDEMNITY
36	PT HARMONI MITRAJAYA	INDEMNITY
37	PT ANDREAN SENTANA	INDEMNITY
38	PT JAYA ADIKARYA DESIGN	INDEMNITY
39	PT JCO DONUT AND COFFEE	INDEMNITY
40	PT MAKO ANUGERAH KREASINDO	INDEMNITY
41	PT ENKEI INDONESIA	INDEMNITY
42	PT ENKEI MARUTOYO PAINTING INDONESIA	INDEMNITY
43	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA	INDEMNITY
44	PT MAHAKARYA KEMILAU ABADI	INDEMNITY
45	PT MAKO ANUGERAH KREASINDO (CKB)	INDEMNITY
46	PT MAKO ANUGERAH KREASINDO (JAP)	INDEMNITY
47	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA II	INDEMNITY
48	PT KRAKATAU POSCO	INDEMNITY
49	PT METRA-NET	INDEMNITY
50	PT SINERGI SOLUSI UTAMA	INDEMNITY
51	PT KRAKATAU SARANA PROPERTI	INDEMNITY
52	PT NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE	INDEMNITY

LAMPIRAN VIII CONTOH KARTU PESERTA

1. Kartu Peserta Layanan VVIP PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)



2. Kartu Peserta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)



3. Kartu Peserta dengan PT AdMedika sebagai Pelayanan Administrasi Kesehatan



4. Kartu Peserta dengan Medlinx sebagai Penyedia Sistem Layanan Kesehatan

